

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1205/I-KEP/DIR/XII/2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RISIKO, REGISTER RISIKO, DAN MITIGASI RISIKO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan adanya kebijakan tentang Penetapan Daftar Risiko, Register Risiko, dan Mitigasi Risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Risiko, Register Risiko dan Mitigasi Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107/Menkes/1596/2024 tentang Standard Akreditasi RS
12. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PENETAPAN DAFTAR RISIKO, REGISTER RISIKO DAN MITIGASI RISIKO
Kedua : Masa berlaku daftar risiko, register risiko dan mitigasi risiko yakni 01 Januari 2026 – 31 Desember 2026 sebagaimana dimaksud Diketum adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan pada peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1205/I-KEP/DIR/XII/2025
TENTANG PENETAPAN
DAFTAR RISIKO, REGISTER
RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

A. DAFTAR RISIKO DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

1. Daftar Risiko Rumah Sakit

No	Kategori Risiko	Daftar Risiko
1.	Risiko Klinis	Risiko kesalahan klinis dalam proses asuhan pasien, meliputi: kesalahan pemberian obat (medication error), kesalahan identifikasi pasien, infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs), risiko jatuh, kesalahan prosedur tindakan medis/operasi, reaksi anestesi, serta penularan infeksi pada petugas akibat paparan darah/cairan tubuh.
2.	Risiko Non Klinis	Risiko yang tidak berkaitan langsung dengan proses klinis.
	a. Risiko Kebijakan	Risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan internal rumah sakit, termasuk ketidakseragaman implementasi regulasi, distribusi kebijakan yang tidak merata, dan keterlambatan tindak lanjut keputusan pimpinan.
	b. Risiko Reputasi	Risiko penurunan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, meliputi: penyebaran informasi negatif di media digital/sosial, keluhan viral, keterlambatan pelayanan yang menimbulkan komplain, dan kekerasan terhadap petugas yang mencoreng nama baik institusi.
	c. Risiko Fraud	Risiko kecurangan atau penyimpangan yang merugikan rumah sakit secara finansial, meliputi: kehilangan atau penyimpangan barang gudang, pencurian uang kas, dan manipulasi data atau transaksi keuangan.
	d. Risiko Legal	Risiko tuntutan hukum dan sengketa yang dihadapi rumah sakit, meliputi: kebocoran data pasien, tertukarnya jenazah, kehilangan/kerusakan berkas rekam medis, sengketa pembayaran pasien, dan sengketa hubungan kerja dengan staf.
	e. Risiko Kepatuhan	Risiko akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, standar, dan persyaratan perizinan, meliputi: tenaga kesehatan berpraktik dengan SIP/STR tidak berlaku, korsleting listrik akibat tidak terpeliharanya instalasi, dan keterlambatan dokumentasi hasil rapat.
	f. Risiko Operasional	Risiko gangguan pada proses operasional pelayanan rumah sakit, meliputi: kegagalan sistem jaringan/IT, kerusakan alat medis akibat pemeliharaan tidak optimal, kekurangan SDM, kekosongan stok barang, gangguan sistem informasi, dan overload pekerjaan



		petugas.
--	--	----------

2. Daftar Risiko Unit

No	Nama Unit	Daftar Risiko
1	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	1. Risiko kegagalan dalam penentuan lokasi operasi akibat ketidakpatuhan surgical safety checklist dan komunikasi buruk 2. Risiko infeksi luka operasi akibat ketidakpatuhan bundle pencegahan infeksi 3. Risiko reaksi anestesi berat akibat ketidaktepatan pemberian anestesi
2	Unit IT	1. Risiko pelayanan terganggu akibat kegagalan sistem jaringan 2. Risiko kehilangan data penting rumah sakit akibat tidak adanya backup data 3. Risiko kebocoran data pasien akibat perlindungan data elektronik tidak optimal
3	Instalasi Rawat Jalan	1. Risiko keterlambatan pelayanan akibat dokter datang tidak sesuai jadwal 2. Risiko penularan infeksi airborne akibat ketidakpatuhan pasien TB menggunakan masker 3. Risiko pelayanan terganggu akibat AC tidak berfungsi optimal
4	Driver	1. Risiko kecelakaan operasional kendaraan rumah sakit akibat unsafe action dan unsafe condition 2. Risiko paparan penyakit akibat petugas tidak menggunakan APD saat penjemputan/pengantaran pasien 3. Risiko keterlambatan transportasi pasien akibat jumlah permintaan operasional melebihi kapasitas driver
5	ATEM	1. Risiko paparan radiasi pada pasien akibat error alat CT Scan 2. Risiko ketidaksesuaian pemberian cairan/obat akibat error pada Syringe Pump 3. Risiko hasil monitoring ECG tidak akurat akibat gel elektroda mengering atau berkerak
6	IPSRs	1. Risiko pelayanan terganggu akibat kerusakan alat karena pemeliharaan dan pengecekan tidak optimal 2. Risiko kelelahan kerja petugas akibat overload pekerjaan 3. Risiko tersengat listrik saat pemeriksaan atau perbaikan alat akibat kebocoran arus listrik
7	Laundry	1. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat proses dekontaminasi linen terkontaminasi yang tidak optimal 2. Risiko penularan infeksi akibat penanganan linen infeksius yang tidak sesuai prosedur 3. Risiko needle stick injury pada petugas akibat benda tajam tercampur dalam linen kotor



No	Nama Unit	Daftar Risiko
8	CSSD	1. Risiko penularan infeksi pada petugas akibat paparan darah atau cairan tubuh saat proses dekontaminasi 2. Risiko infeksi pada petugas akibat paparan alat kotor atau terkontaminasi saat proses penerimaan alat 3. Risiko infeksi nosokomial (HAIs) pada pasien akibat kontaminasi silang alat kesehatan
9	Cleaning Service	1. Risiko needle stick injury pada petugas cleaning service akibat jarum bekas tercampur dalam sampah atau linen medis 2. Risiko penularan infeksi pada petugas cleaning service akibat paparan lingkungan atau permukaan terkontaminasi 3. Risiko cedera akibat terpeleset pada lantai licin saat kegiatan pembersihan
10	Kamar Jenazah	1. Risiko penularan penyakit infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak standar atau robek 2. Risiko tertukarnya jenazah akibat kegagalan identifikasi 3. Risiko kesalahan identifikasi dan keterlambatan pelayanan akibat ketidaklengkapan pencatatan data transit jenazah
11	Keamanan	1. Risiko gangguan pengawasan keamanan akibat CCTV rusak atau tidak berfungsi optimal 2. Risiko penularan penyakit infeksi pada petugas security saat membantu pemindahan pasien 3. Risiko kekerasan verbal maupun fisik dari keluarga pasien terhadap petugas terkait kebijakan jam besuk
12	Instalasi Rawat Inap 2A	1. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 2. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD 3. Risiko ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan pasien akibat gangguan SIMRS saat pengisian E-RM
13	Instalasi Rawat Inap 2C	1. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 2. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD 3. Risiko penularan infeksi akibat pengunjung masuk tanpa izin dan tidak sesuai prosedur
14	Instalasi Rawat Inap 3A	1. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 2. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD 3. Risiko ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan pasien akibat gangguan SIMRS saat pengisian E-RM



No	Nama Unit	Daftar Risiko
15	Instalasi Rawat Inap 3C	1. Risiko penularan infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak lengkap saat kontak dengan pasien 2. Risiko infeksi nosokomial akibat petugas tidak melakukan hand hygiene saat tindakan invasif 3. Risiko pasien jatuh akibat handrail tempat tidur tidak terpasang
16	Instalasi Rawat Inap 4A	1. Risiko pasien mengalami nyeri, hematoma, atau komplain akibat penusukan vena lebih dari dua kali 2. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 3. Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD
17	Instalasi Rawat Inap 5C	1. Risiko penularan infeksi akibat penanganan pasien infeksius yang tidak sesuai prosedur 2. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi 3. Risiko peningkatan infeksi akibat ketidakpatuhan hand hygiene
18	Instalasi Rawat Inap 6A	1. Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf 2. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 3. Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD
19	Instalasi Rawat Inap 7A	1. Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf 2. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 3. Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD
20	Instalasi Rawat Inap 8A	1. Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf 2. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 3. Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD
21	Instalasi Gawat Darurat	1. Risiko kesalahan terapi atau tindakan akibat miskomunikasi antar tenaga kesehatan 2. Risiko perburukan kondisi pasien akibat keterlambatan pemberian tindakan awal di IGD 3. Risiko penularan infeksi pada petugas maupun pasien lain akibat penanganan pasien infeksius di IGD
22	Instalasi Care Unit	1. Risiko terjadinya infeksi VAP akibat audit bundle pencegahan yang tidak dilakukan secara rutin 2. Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf 3. Risiko penularan infeksi akibat tindakan aerosol yang tidak dilakukan secara aman



No	Nama Unit	Daftar Risiko
23	Instalasi Gizi	1. Risiko kondisi pasien memburuk akibat pemberian diet yang tidak sesuai 2. Risiko malnutrisi tidak teridentifikasi akibat skrining nutrisi yang tidak dilakukan 3. Risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan diet pasien akibat kekurangan stok bahan makanan
24	Radiologi	1. Risiko kesalahan identifikasi pasien yang dapat menyebabkan pemeriksaan atau tindakan radiologi tidak sesuai 2. Risiko terganggunya pelayanan radiologi akibat kekurangan staf 3. Risiko keterlambatan pemeriksaan pasien akibat gangguan atau kerusakan alat CT Scan
25	Laboratorium	1. Risiko kesalahan hasil pemeriksaan dan diagnosis akibat identifikasi pasien atau spesimen yang tidak tepat 2. Risiko keterlambatan pelayanan dan human error akibat kekurangan SDM laboratorium 3. Risiko needle stick injury pada petugas laboratorium akibat penanganan jarum atau benda tajam yang tidak aman
26	Komite K3RS	1. Risiko terganggunya pelayanan akibat kerusakan alat dan kegagalan uji fungsi 2. Risiko kelelahan kerja dan penurunan kesehatan staf akibat overload pekerjaan 3. Risiko korsleting atau sengatan listrik akibat kabel listrik terbuka
27	Tim PKRS	1. Risiko kesalahan penyampaian informasi medis saat pergantian shift akibat ketidakpatuhan terhadap SPO Komunikasi Efektif 2. Risiko ketidakpatuhan pasien terhadap instruksi medis akibat kendala bahasa dan penggunaan istilah medis 3. Risiko edukasi kesehatan tidak tersampaikan secara optimal akibat informasi dan media edukasi yang tidak diperbarui
28	Komite PPI	1. Risiko terjadinya Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAI) akibat penerapan PPI yang belum optimal 2. Risiko penyebaran mikroorganisme akibat ketidakpatuhan hand hygiene 5 momen 3. Risiko paparan dan penularan infeksi akibat penggunaan APD yang tidak adekuat
29	SDM	1. Risiko ketidakstabilan tenaga kerja akibat tingginya turnover staf yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan 2. Risiko tenaga kesehatan berpraktik dengan SIP yang tidak berlaku sehingga menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan regulasi 3. Risiko sengketa hubungan kerja akibat



No	Nama Unit	Daftar Risiko
		pengelolaan kontrak dan dokumen kepegawaian yang tidak tertib
30	Humas & Marketing	1. Risiko penurunan citra rumah sakit akibat penyebaran informasi negatif atau keluhan pasien di media digital 2. Risiko menurunnya kepercayaan masyarakat akibat komentar, review, atau pemberitaan negatif yang viral 3. Risiko miskomunikasi kepada masyarakat dan stakeholder akibat penyampaian informasi digital yang tidak terkontrol
31	Farmasi	1. Risiko kesalahan pelayanan dan pemberian obat akibat kelelahan petugas farmasi yang bekerja lebih dari 8 jam 2. Risiko kesalahan penginputan e-resep yang dapat menyebabkan cedera atau membahayakan pasien 3. Risiko kesalahan penyiapan obat LASA yang dapat menyebabkan salah obat atau salah pasien
32	Maternitas	1. Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat 2. Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD 3. Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kondisi AC bocor di ruang maternitas
33	Neonatologi	1. Risiko terganggunya pelayanan pasien neonatus akibat kegagalan fasilitas dan infrastruktur (inkubator, listrik, gas medis) 2. Risiko cedera jaringan, nekrosis, atau deformitas hidung akibat pemasangan nasal CPAP yang tidak optimal 3. Risiko tertukarnya identitas bayi yang dapat menyebabkan kesalahan pemberian advis maupun pelayanan
34	Rekam Medis	1. Risiko kehilangan data rekam medis akibat tidak tersedianya backup data yang memadai 2. Risiko kehilangan atau kerusakan berkas rekam medis yang dapat menyebabkan hambatan pelayanan dan tuntutan hukum 3. Risiko kesalahan atau ketidaklengkapan data pasien akibat ketidaktelitian petugas dalam verifikasi berkas rekam medis
35	Kesekretariatan	1. Risiko kehilangan dokumen penting akibat pengelolaan dan pengarsipan surat masuk maupun surat keluar yang tidak tertib 2. Risiko ketidakseragaman implementasi kebijakan akibat distribusi dan sosialisasi regulasi yang tidak merata 3. Risiko keterlambatan tindak lanjut keputusan rapat akibat dokumentasi dan monitoring hasil rapat yang tidak optimal



No	Nama Unit	Daftar Risiko
36	Gudang Umum	1. Risiko terganggunya operasional pelayanan akibat kekosongan stok barang habis pakai 2. Risiko kerusakan atau penurunan kualitas barang akibat penyimpanan gudang yang tidak sesuai standar 3. Risiko kehilangan atau penyimpangan barang yang menyebabkan kerugian finansial rumah sakit
37	Asuransi Center	1. Risiko keterlambatan proses klaim akibat gangguan sistem e-klaim yang berdampak pada arus kas rumah sakit 2. Risiko penurunan kinerja petugas akibat kelelahan dan stres kerja karena beban kerja yang tinggi 3. Risiko kelelahan mata dan penurunan konsentrasi akibat paparan layar komputer secara terus-menerus
38	MOD-MPP-PIPP	1. Risiko kekerasan verbal atau fisik terhadap petugas akibat keluarga pasien yang emosional dan miskomunikasi di unit PIPP 2. Risiko pencemaran nama baik rumah sakit akibat ketidakpuasan dan miskomunikasi pelayanan 3. Risiko viral negatif di media sosial yang dapat menurunkan kepercayaan pasien dan mencemarkan nama baik rumah sakit
39	Pendaftaran	1. Risiko keterlambatan pelayanan dan kesalahan identifikasi pasien akibat gangguan internet/jaringan pada sistem rumah sakit 2. Risiko klaim pelayanan tidak dapat diproses akibat SEP tidak tercetak 3. Risiko terjadinya rekam medis ganda akibat ketidaklengkapan data saat proses pendaftaran yang dapat menyebabkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
40	Rehab Medis	1. Risiko penurunan efektivitas rehabilitasi akibat keterbatasan waktu pelayanan, ruang, dan fasilitas terapi latihan 2. Risiko keterlambatan pelayanan akibat jumlah fisioterapis yang tidak seimbang dengan beban pelayanan 3. Risiko cedera pasien dan gangguan pelayanan akibat peralatan rehabilitasi yang tidak dikalibrasi atau dipelihara secara berkala
41	Kasir	1. Risiko pencurian uang kas akibat area kasir yang terbuka dan petugas jaga malam bekerja sendiri 2. Risiko keterlambatan pelayanan akibat gangguan sistem informasi kasir/SIMRS 3. Risiko sengketa pembayaran akibat kesalahan penghitungan atau penagihan biaya layanan pasien



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

B. REGISTER RISIKO DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

1. Instalasi Kamar Operasi

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena ketidakpatuhan surgical safety checklist tidak diisi lengkap, dan komunikasi tim buruk sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi yang akan dioperasi	Ketidakpatuhan terhadap checklist dan komunikasi buruk	5	3	53	15	3
2	Risiko Klinis	Karena ketidakpatuhan terhadap bundle pencegahan infeksi dapat menyebabkan infeksi luka operasi yang berdampak pada keselamatan pasien	Sterilisasi tidak optimal, kepatuhan bundle PPI rendah	4	3	43	12	4
3	Risiko Klinis	Karena ketidaktepatan pemberian anestesi dapat menyebabkan reaksi berat yang membahayakan keselamatan pasien.	Alergi tidak terdeteksi, kesalahan dosi	4	3	43	12	4



2. Unit IT

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena terjadi kegagalan sistem jaringan kemungkinan terjadinya downtime pada jaringan sehingga menyebabkan pelayanan terganggu	Terjadi kegagalan sistem	4	4	44	16	2
2	Risiko Operasional	Karena tidak ada <i>back up</i> data kemungkinan kehilangan data penting rumah sakit sehingga menghambat operasional pelayanan	Monitoring <i>back up</i> data belum optimal	4	4	44	16	2
3	Risiko Legal	Karena perlindungan data elektronik tidak optimal kemungkinan terjadi kebocoran data pasien sehingga rumah sakit terkena tuntutan hukum	Kurangnya edukasi cyber security pada petugas	4	3	43	12	4

3. Instalasi Rawat Jalan

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Reputasi	Karena keterlambatan	Disiplin ketepatan	3	5	35	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		kedatangan dokter tidak sesuai jadwal pelayanan, kemungkinan terjadi keterlambatan pemeriksaan pasien sehingga menimbulkan komplain pasien dan menurunkan kepuasan terhadap pelayanan rumah sakit.	waktu dokter belum optimal dan koordinasi jadwal pelayanan belum berjalan efektif.					
2	Risiko Klinis	Karena ketidakpatuhan pasien TB dalam penggunaan masker, berpotensi terjadi transmisi penyakit infeksi airborne di area pelayanan rumah sakit sehingga mengganggu keselamatan pasien, pengunjung rumah sakit dan petugas.	Kepatuhan pasien terhadap pencegahan infeksi rendah	4	3	43	12	4
3	Risiko Operasional	Karena AC tidak berfungsi optimal atau tidak dingin, kemungkinan terjadi ketidaknyamanan pada pasien dan	Pemeliharaan dan servicing AC tidak rutin	3	4	34	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		petugas sehingga menurunkan kualitas pelayanan di rumah sakit.						

4. Driver

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena perilaku berkendara tidak aman (<i>unsafe action</i>) dan kondisi kerja yang tidak aman (<i>unsafe condition</i>), berpotensi terjadi kecelakaan operasional kendaraan rumah sakit yang mengakibatkan cedera hingga kematian pada staf atau pasien.	Kepatuhan driver terhadap SOP keselamatan berkendara rendah dan kurangnya monitoring.	4	2	42	8	7
2	Risiko Klinis	Karena ketidakpatuhan petugas dalam menggunakan APD saat melakukan penjemputan atau pengantaran pasien kemungkinan staf terpapar pajanan	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD masih rendah	3	2	32	6	8



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		cairan tubuh pasien sehingga menyebabkan staf dapat mengalami penularan penyakit						
3	Risiko Operasional	Karena jumlah permintaan operasional melebihi kapasitas driver yang tersedia, berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan transportasi pasien dan peningkatan beban kerja petugas.	Koordinasi antar unit kurang efektif	3	2	32	6	8

5. ATEM

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena terjadi <i>error</i> pada alat <i>CT Scan</i> akibat kurangnya monitoring dan pengawasan, kemungkinan terjadi paparan radiasi berlebih kepada pasien sehingga meningkatkan risiko	SOP penggunaan dan pengecekan alat belum dijalankan secara optimal.	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		efek radiasi terhadap kesehatan pasien.						
2	Risiko Klinis	Karena intensitas pemakaian <i>Syringe Pump</i> yang tinggi, kemungkinan terjadi error pada alat sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu pemberian dan jumlah cairan atau obat yang masuk ke pasien.	Intensitas penggunaan <i>Syringe Pump</i> yang tinggi tanpa diimbangi pemeliharaan berkala.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena adanya gel elektroda yang mengering atau berkerak pada <i>Electrocardiography</i> , kemungkinan sinyal ECG tidak terbaca dengan baik sehingga hasil monitoring atau perekaman aktivitas jantung menjadi tidak akurat.	Pembersihan alat dan aksesori ECG tidak dilakukan secara rutin.	3	2	32	6	8

6. IPSRS

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko	Karena petugas tidak	SOP	4	5	45	20	1



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
	Operasional	melakukan pemeliharaan alat, maka berisiko alat rusak, kegagalan uji fungsi dan sehingga pelayanan dapat terganggu	pemeliharaan dan pengecekan alat belum dijalankan secara optimal.					
2	Risiko Operasional	Karena terdapat overload pekerjaan pada petugas, kemungkinan terjadi kelelahan kerja sehingga meningkatkan risiko staf mengalami gangguan kesehatan atau sakit.	Tingginya volume pekerjaan dalam waktu bersamaan..	4	4	44	16	2
3	Risiko Operasional	Karena adanya kerusakan isolasi kabel atau kebocoran arus pada peralatan listrik dan alat kesehatan, kemungkinan petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mengalami sengatan listrik saat melakukan pemeriksaan, perbaikan, atau pemeliharaan alat.	Adanya kebocoran arus listrik pada alat.	3	3	33	9	6

7. Laundry

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena proses dekontaminasi linen terkontaminasi tidak dilakukan dengan penanganan yang optimal, kemungkinan petugas terpapar darah, cairan tubuh, aerosol infeksius, dan kontaminasi silang sehingga meningkatkan risiko penularan infeksi.	Penggunaan APD saat proses dekontaminasi linen belum optimal.	5	3	53	15	3
2	Risiko Klinis	Karena penanganan linen infeksius tidak dilakukan sesuai prosedur pencegahan infeksi, kemungkinan terjadi penularan airborne, droplet, maupun contact kepada petugas sehingga meningkatkan risiko penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit.	Penanganan linen infeksius tidak sesuai prosedur PPI	5	3	53	15	3
3	Risiko Klinis	Karena benda tajam seperti jarum atau alat medis tercampur	Pemisahan benda tajam dan limbah	5	3	53	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		dalam linen kotor, kemungkinan petugas mengalami <i>needle stick injury</i> sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi akibat pajanan darah dan cairan tubuh.	medis tidak dilakukan sesuai prosedur.					

8. CSSD

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena petugas terpapar darah atau cairan tubuh saat proses dekontaminasi, kemungkinan terjadi penularan infeksi sehingga membahayakan kesehatan petugas.	Penggunaan APD saat proses dekontaminasi belum sesuai standar.	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Karena petugas terpapar alat kotor atau terkontaminasi saat proses penerimaan alat, kemungkinan terjadi infeksi akibat paparan mikroorganisme	Kepatuhan terhadap SOP penerimaan alat kotor masih kurang.	4	4	44	16	2



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		patogen sehingga membahayakan kesehatan petugas.						
3	Risiko Klinis	Karena terjadi kontaminasi silang pada alat kesehatan akibat proses pembersihan dan sterilisasi yang tidak optimal, kemungkinan pasien mengalami infeksi nosokomial atau <i>Healthcare Associated Infections</i> (HAIs).	Pemisahan alat bersih dan alat kotor belum dilakukan dengan baik	5	3	53	15	3

9. Cleaning Service

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena benda tajam seperti jarum bekas tercampur dalam sampah atau linen medis, kemungkinan petugas cleaning service mengalami tertusuk jarum (<i>needle stick injury</i>) sehingga berisiko terpapar darah dan tertular penyakit	Jarum bekas tidak dibuang langsung ke safety box sesuai prosedur.	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		infeksi.						
2	Risiko Klinis	Karena petugas cleaning service terpapar lingkungan, limbah, atau permukaan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen saat bekerja, kemungkinan terjadi penularan penyakit infeksi kepada petugas maupun lingkungan sekitar.	Penggunaan APD oleh petugas cleaning service belum sesuai standar.	3	3	33	9	6
3	Risiko Operasional	Karena lantai licin akibat tumpahan cairan atau proses pembersihan, kemungkinan petugas cleaning service terpeleset dan mengalami cedera saat bekerja.	Tumpahan cairan tidak segera dibersihkan.	3	3	33	9	6

10. Kamar Jenazah

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena menggunakan APD yang tidak standar atau robek	Karena menggunakan APD yang tidak	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		kemungkinan petugas terpapar penyakit menular (misal: Hepatitis, HIV, atau Covid-1) sehingga menyebabkan gangguan kesehatan serius pada petugas, potensi wabah di lingkungan RS	standar atau robek					
2	Risiko Legal	Karena gelang identitas lepas atau petugas tidak melakukan verifikasi ganda kemungkinan jenazah tertukar saat diserahkan kepada pihak keluarga sehingga mengakibatkan tuntutan hukum, konflik keluarga, dan pencemaran nama baik RS	Karena gelang identitas lepas atau petugas tidak melakukan verifikasi ganda	5	2	52	10	5
3	Risiko Operasional	Karena ketidaklengkapan pencatatan data transit jenazah, kemungkinan terjadi kesalahan identifikasi, keterlambatan proses pelayanan, maupun	Kurangnya koordinasi antarunit terkait proses transit jenazah.	3	2	32	6	8



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		ketidaksesuaian informasi jenazah sehingga dapat mengganggu pelayanan dan menimbulkan komplain dari keluarga pasien.						

11. Keamanan

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Terdapat risiko gangguan pengawasan keamanan akibat CCTV rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga kejadian kehilangan, pencurian, vandalisme, maupun insiden keamanan lainnya tidak dapat terpantau dan ditindaklanjuti secara efektif.	Belum optimalnya program pemeliharaan preventif dan monitoring kondisi CCTV sehingga kerusakan tidak terdeteksi atau tidak segera ditangani.	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Petugas keamanan (<i>security</i>) yang sering membantu mengangkat atau	Belum adanya pengaturan dan sosialisasi yang jelas mengenai	3	5	35	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		memindahkan pasien di area IGD berisiko terpapar dan tertular penyakit infeksi dari pasien akibat kontak dekat tanpa penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada petugas dan penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit.	batas kewenangan security dalam membantu pemindahan pasien serta kurangnya penerapan PPI dan penggunaan APD yang sesuai					
3	Risiko Reputasi	Terdapat risiko terjadinya kekerasan verbal maupun fisik dari keluarga pasien terhadap petugas saat dilakukan penjelasan mengenai kebijakan atau pembatasan jam besuk, yang dapat menyebabkan cedera petugas, gangguan keamanan, dan terganggunya pelayanan rumah sakit.	Kurangnya pemahaman keluarga pasien terhadap kebijakan jam besuk serta belum optimalnya komunikasi dan pengelolaan konflik saat penyampaian informasi oleh petugas.	3	3	33	9	6



12. Instalasi Rawat Inap 2A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan keluhan dari pasien maupun keluarga	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6
2	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpapar infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6
3	Risiko Operasional	Karena SIMRS mengalami error, berisiko terjadi gangguan dalam pengisian E-RM	Gangguan sistem/aplikasi SIMRS saat proses input data.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		sehingga terdapat beberapa bagian data yang tidak terisi lengkap dan dapat mempengaruhi kelengkapan dokumentasi pelayanan pasien.						

13. Instalasi Rawat Inap 2C

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan komplain dari pasien maupun keluarga	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6
2	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		sehingga dapat menyebabkan terpajan infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.						
3	Risiko Klinis	Karena pengunjung masuk tanpa izin dan tidak sesuai prosedur, mungkin saja terjadi paparan serta penularan infeksi sehingga dapat membahayakan pasien, pengunjung, maupun petugas rumah sakit.	Pengawasan keluar masuk pengunjung belum optimal.	3	3	33	9	6

14. Instalasi Rawat Inap 3A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan,	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		serta menimbulkan komplain dari pasien maupun keluarga						
2	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpajan infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6
3	Risiko Operasional	Karena SIMRS mengalami error, berisiko terjadi gangguan dalam pengisian E-RM sehingga terdapat beberapa bagian data yang tidak terisi lengkap dan dapat mempengaruhi kelengkapan dokumentasi pelayanan pasien.	Gangguan sistem/aplikasi SIMRS saat proses input data.	3	3	33	9	6

15. Instalasi Rawat Inap 3C



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena perawat tidak menggunakan APD secara lengkap, mungkin saja terjadi penularan melalui droplet dan kontak sehingga dapat menyebabkan petugas yang kontak langsung dengan pasien menjadi terpajan atau terinfeksi.	Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar belum optimal.	3	3	33	9	6
2	Risiko Klinis	Karena petugas tidak melakukan cuci tangan saat melakukan tindakan invasif, mungkin saja terjadi penularan rantai penyakit sehingga dapat menimbulkan infeksi nosokomial kepada pasien maupun petugas.	Kepatuhan petugas terhadap hand hygiene belum optimal.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena handrail pasien tidak terpasang, mungkin saja pasien mengalami jatuh sehingga dapat menyebabkan	Petugas kurang memastikan pemasangan handrail setelah tindakan/perawatan.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		cedera pada pasien.						

16. Instalasi Rawat Inap 4A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena terdapat penusukan vena lebih dari 2 kali, mungkin saja pasien mengalami dehidrasi dan ketidaktepatan lokasi penusukan sehingga dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan dan menimbulkan komplain.	Kondisi vena pasien sulit ditemukan akibat dehidrasi.	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan komplain dari pasien maupun keluarga	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena penggunaan	Kepatuhan	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpapar infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.					

17. Instalasi Rawat Inap 5C

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena pasien infeksius tidak ditangani dengan benar, mungkin saja terjadi penularan melalui droplet dan kontak sehingga dapat menyebabkan penyebaran infeksi kepada pasien lain, pengunjung, maupun petugas.	Kepatuhan terhadap prosedur PPI belum optimal.	5	3	53	15	3
2	Risiko Klinis	Karena APD tidak digunakan sesuai indikasi, mungkin saja petugas terpapar infeksi sehingga dapat	Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar belum optimal.	5	3	53	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		membahayakan keselamatan petugas dan meningkatkan risiko penularan.						
3	Risiko Klinis	Karena hand hygiene tidak dilakukan, mungkin saja terjadi peningkatan penyebaran kuman sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi pada pasien maupun petugas.	Kepatuhan petugas terhadap hand hygiene belum optimal.	5	3	53	15	3

18. Instalasi Rawat Inap 6A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena jumlah staf kurang, mungkin saja pelayanan menjadi tidak optimal sehingga dapat menyebabkan terganggunya layanan kepada pasien.	Distribusi jadwal dan pembagian tugas belum optimal.	4	3	43	12	4
2	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan keluhan dari pasien maupun keluarga	pemberian obat.					
3	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpapar infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6

19. Instalasi Rawat Inap 7A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena jumlah staf kurang, mungkin saja pelayanan menjadi tidak optimal sehingga dapat menyebabkan terganggunya layanan kepada pasien.	Distribusi jadwal dan pembagian tugas belum optimal.	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
2	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan komplain dari pasien maupun keluarga	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpajan infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6

20. Instalasi Rawat Inap 8A

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena jumlah staf kurang, mungkin saja pelayanan menjadi tidak optimal	Distribusi jadwal dan pembagian tugas belum	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		sehingga dapat menyebabkan terganggunya layanan kepada pasien.	optimal.					
2	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan keluhan dari pasien maupun keluarga	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpapar infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6

21. Instalasi Gawat Darurat



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena terjadi miskomunikasi antar tenaga kesehatan, mungkin saja terjadi kesalahan terapi maupun tindakan yang tidak sesuai sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien.	Kurangnya konfirmasi ulang terhadap instruksi atau advis medis.	4	5	45	20	1
2	Risiko Klinis	Karena terjadi keterlambatan dalam pemberian tindakan awal pada pasien gawat darurat di IGD, mungkin saja kondisi pasien memburuk sehingga dapat meningkatkan risiko komplikasi maupun keselamatan pasien.	Keterlambatan respons tenaga kesehatan terhadap pasien gawat darurat.	4	3	43	12	4
3	Risiko Klinis	Karena penanganan pasien infeksius di IGD, mungkin saja terjadi penularan melalui droplet, kontak, maupun paparan benda tajam sehingga dapat menyebabkan petugas atau pasien lain terpapar infeksi.	Kepatuhan penggunaan APD dan kewaspadaan standar belum optimal.	3	3	33	9	6



22. Instalasi Care Unit

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena audit bundle tidak dilakukan secara rutin, mungkin saja kepatuhan terhadap bundle pencegahan tidak terpantau sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi VAP.	Kurangnya supervisi dan tindak lanjut hasil audit.	5	3	53	15	3
2	Risiko Operasional	Karena jumlah staf kurang, mungkin saja pelayanan menjadi tidak optimal sehingga dapat menyebabkan terganggunya layanan kepada pasien.	Distribusi jadwal dan pembagian tugas belum optimal.	4	3	43	12	4
3	Risiko Klinis	Karena tindakan aerosol tidak dilakukan dengan aman, mungkin saja terjadi penyebaran droplet atau aerosol sehingga dapat meningkatkan risiko penularan infeksi	Kepatuhan terhadap prosedur tindakan aerosol belum optimal.	5	2	52	10	5

23. Instalasi Gizi



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena pemberian diet tidak sesuai, mungkin saja kebutuhan nutrisi pasien tidak terpenuhi sehingga dapat menyebabkan kondisi pasien memburuk.	Verifikasi jenis diet pasien belum dilakukan secara optimal.	4	3	43	12	4
2	Risiko Klinis	Karena pasien tidak dilakukan skrining nutrisi, mungkin saja kondisi malnutrisi tidak teridentifikasi sehingga penanganan nutrisi pasien menjadi terlambat atau tidak optimal.	Kepatuhan pelaksanaan skrining nutrisi belum optimal.	4	3	43	12	4
3	Risiko Operasional	Karena stok bahan makanan atau kebutuhan gizi habis, mungkin saja penyediaan diet pasien menjadi terlambat atau tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan terganggunya pelayanan gizi kepada pasien.	Monitoring stok bahan makanan belum dilakukan secara rutin.	4	3	43	12	4

24. Radiologi



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena identifikasi pasien oleh petugas radiologi kurang optimal dan hanya berfokus pada informasi dari petugas rawat inap tanpa melakukan double check langsung kepada pasien maupun SIMRS, mungkin saja terjadi kesalahan identifikasi sehingga dapat menyebabkan pemeriksaan atau tindakan tidak sesuai pada pasien	Kepatuhan terhadap prosedur identifikasi pasien belum optimal.	3	4	34	12	4
2	Risiko Operasional	Karena jumlah staf kurang, mungkin saja pelayanan menjadi tidak optimal sehingga dapat menyebabkan terganggunya layanan kepada pasien.	Distribusi jadwal dan pembagian tugas belum optimal.	4	3	43	12	4
3	Risiko Operasional	Karena alat CT Scan mengalami trouble, mungkin saja proses pemeriksaan pasien tertunda sehingga	Pemeliharaan dan pengecekan alat belum optimal.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		dapat menyebabkan terganggunya pelayanan radiologi.						

25. Laboratorium

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena identifikasi pasien maupun spesimen tidak dilakukan dengan benar, mungkin saja terjadi kesalahan hasil pemeriksaan dan diagnosis sehingga dapat menyebabkan penatalaksanaan pasien menjadi tidak sesuai.	Kepatuhan terhadap prosedur identifikasi pasien dan spesimen belum optimal.	4	4	44	16	2
2	Risiko Operasional	Karena jumlah SDM di laboratorium kurang, mungkin saja petugas mengalami kelelahan dan human error sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan maupun kesalahan dalam pemeriksaan laboratorium.	Tingginya volume pemeriksaan dalam waktu tertentu.	4	4	44	16	2



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
3	Risiko Klinis	Karena penanganan jarum atau benda tajam tidak dilakukan dengan aman, mungkin saja terjadi needle stick injury sehingga dapat menyebabkan paparan infeksi kepada petugas laboratorium.	Kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja belum optimal.	5	3	53	15	3

26. Komite K3RS

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena petugas tidak melakukan pemeliharaan alat secara rutin, mungkin saja terjadi kerusakan alat dan kegagalan uji fungsi sehingga dapat menyebabkan terganggunya pelayanan.	Kepatuhan terhadap jadwal pemeliharaan alat belum optimal.	4	5	45	20	1
2	Risiko Reputasi	Karena terdapat overload pekerjaan, mungkin saja staf mengalami kelelahan sehingga dapat menyebabkan kondisi	Pembagian tugas dan jadwal kerja belum optimal.	4	4	44	16	2



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		kesehatan staf menurun atau sakit.						
3	Risiko Kepatuhan	Karena kabel listrik terbuka tidak segera diamankan atau diperbaiki, mungkin saja terjadi korsleting maupun sengatan listrik sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien, pengunjung, dan petuga	Monitoring kondisi sarana dan instalasi listrik belum rutin dilakukan.	3	3	33	9	6

27. Tim PKRS

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Dikarenakan Petugas tidak mematuhi SPO Komunikasi Efektif terkait pemberian informasi medis, kemungkinan mengakibatkan kesalahan penyampaian informasi kondisi medis pasien saat pergantian shift sehingga Pasien/keluarga bingung, menolak tindakan medis, atau salah persepsi terhadap penyakitnya.	Dikarenakan Petugas tidak mematuhi SPO Komunikasi Efektif terkait pemberian informasi medis..	3	4	34	12	4
2	Risiko Klinis	Dikarenakan kendala	Dikarenakan	3	2	32	6	8



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		bahasa dan adanya istilah medis kemungkinan pasien tidak paham instruksi medis sehingga terjadi ketidakpatuhan minum obat/prosedur	kendala bahasa dan adanya istilah medis.					
3	Risiko Operasional	Dikarenakan petugas tidak memperbarui informasi sesuai dengan informasi/peraturan terbaru, kebingungan petugas dalam menggunakan media edukasi yang sesuai dengan kondisi lapangan Kemungkinan edukasi kesehatan tidak diterima dengan maksimal oleh pasien, keluarga dan pengunjung pasien sehingga pasien/keluarga/pengunjung mengalami kebingungan dalam menerima segala sumber informasi	Dikarenakan petugas tidak memperbarui informasi sesuai dengan informasi/pertaturan terbaru, kebingungan petugas dalam menggunakan media edukasi yang sesuai dengan kondisi lapangan	1	2	12	2	10

28. Komite PPI

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena belum optimalnya penerapan	Implementasi bundle pencegahan	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		pengecehan dan pengendalian infeksi, mungkin saja terjadi Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs) seperti SSI, CAUTI, VAP, dan CLABSI/PLABSI sehingga dapat meningkatkan morbiditas, lama rawat, dan beban biaya perawatan pasien	HAIs (SSI, CAUTI, VAP, CLABSI/PLABSI) belum dilakukan secara konsisten di seluruh unit					
2	Risiko Klinis	Karena ketidakpatuhan pelaksanaan hand hygiene 5 momen, mungkin saja terjadi penyebaran mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.	Kepatuhan petugas terhadap hand hygiene 5 momen masih rendah	3	4	34	12	4
3	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD tidak adekuat, mungkin saja terjadi paparan dan penularan infeksi	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD sesuai	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		sehingga dapat membahayakan pasien maupun petugas	indikasi dan standar PPI masih rendah					

29. SDM

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena tingginya turnover staf, mungkin saja terjadi ketidakstabilan tenaga kerja sehingga pelayanan di setiap unit menjadi tidak optimal yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pasien.	Perencanaan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja belum dilakukan secara optimal.	4	3	43	12	4
2	Risiko Kepatuhan	Karena kepatuhan pengurusan SIP (Surat Izin Praktik) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan belum optimal, mungkin saja terdapat tenaga kesehatan yang berpraktik tanpa izin yang masih berlaku sehingga dapat	Sistem monitoring masa berlaku sertifikasi dan kredensial belum terintegrasi.	4	2	42	8	7



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		menimbulkan risiko pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.						
3	Risiko Legal	Karena kontrak dan dokumen kepegawaian tidak dikelola dengan tertib, mungkin saja terjadi sengketa hubungan kerja sehingga dapat menyebabkan tuntutan hukum dan kerugian finansial bagi rumah sakit.	Pengarsipan dokumen kepegawaian belum dilakukan secara sistematis.	3	2	32	6	8

30. Humas & Marketing

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Reputasi	Karena masifnya era digital dan media sosial, informasi negatif atau keluhan pasien dapat dengan cepat tersebar luas sehingga memengaruhi citra rumah sakit	Karena tingginya penggunaan media digital dan kurang optimalnya monitoring media sosial serta manajemen komunikasi publik	4	4	44	16	2
2	Risiko	Adanya komentar,	Karena respons	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
	Reputasi	review, atau pemberitaan viral di platform digital dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit	terhadap isu digital dan keluhan publik belum dilakukan secara cepat dan terstruktur					
3	Risiko Operasional	Penyampaian informasi humas yang tidak terkontrol di media digital dapat menyebabkan miskomunikasi kepada masyarakat dan stakeholder	Karena belum adanya standar komunikasi digital dan verifikasi informasi yang konsisten	3	3	33	9	6

31. Farmasi

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena petugas farmasi bekerja lebih dari 8 jam, mungkin saja petugas mengalami kelelahan sehingga berisiko terjadi kesalahan dalam pelayanan maupun pemberian obat.	Pengaturan jadwal kerja dan waktu istirahat belum optimal.	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Karena petugas tidak teliti saat melakukan	Ketelitian petugas dalam	5	3	53	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		input e-resep, mungkin saja terjadi kesalahan penginputan obat sehingga dapat menyebabkan cedera atau membahayakan pasien.	proses input e-resep belum optimal.					
3	Risiko Klinis	Karena SDM farmasi terbatas dan penyiapan obat LASA tidak dilakukan dengan teliti, mungkin saja terjadi kesalahan penyiapan obat sehingga dapat menyebabkan salah obat maupun salah pasien.	Penerapan double check obat LASA belum konsisten.	5	3	53	15	3

32. Maternitas

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Klinis	Karena tidak dilakukan prinsip 7 benar pemberian obat, berisiko terjadi IKP (Insiden Keselamatan Pasien) yang dapat menyebabkan pasien	Kurangnya ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		merasa kesakitan, ketidaknyamanan, serta menimbulkan komplain dari pasien maupun keluarga						
2	Risiko Klinis	Karena penggunaan APD yang tidak disiplin, berisiko terjadi paparan cairan tubuh pasien kepada staf/perawat sehingga dapat menyebabkan terpajan infeksi dan membahayakan keselamatan petugas.	Kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD belum optimal.	3	3	33	9	6
3	Risiko Operasional	Karena kondisi AC bocor di beberapa ruangan unit maternitas, mungkin terjadi gangguan operasional dan penggunaan ruangan yang tidak maksimal, sehingga pelayanan pasien maternitas dapat terhambat.	Kurangnya pemeliharaan rutin dan preventive maintenance AC.	3	3	33	9	6

33. Neonatologi



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena terjadi kegagalan fasilitas dan infrastruktur, mungkin saja terjadi kegagalan fungsi inkubator, terputusnya aliran listrik, maupun kebocoran gas medis sehingga dapat menyebabkan alat medis tidak berfungsi optimal dan mengganggu pelayanan pasien neonatus.	Pemeliharaan dan pengecekan fasilitas serta alat medis belum optimal.	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Karena tekanan atau gesekan berlebihan saat pemasangan nasal CPAP, mungkin saja terjadi cedera jaringan sehingga dapat menyebabkan nekrosis maupun deformitas pada pasien neonatus.	Monitoring posisi dan tekanan alat belum dilakukan secara optimal.	3	3	33	9	6
3	Risiko Klinis	Karena tidak bekerja dengan hati-hati dan tidak sesuai SPO kemungkinan identitas bayi tertukar	Karena tidak bekerja dengan hati-hati dan tidak sesuai SPO	4	2	42	8	7



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		(kelamin laki-laki/perempuan) sehingga bayi tertukar dan kesalahan pemberian advice						

34. Rekam Medis

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena tidak tersedia backup data rekam medis, mungkin saja terjadi kehilangan data sehingga dapat mengganggu pelayanan, pelacakan riwayat pasien, maupun proses administrasi rumah sakit.	Sistem backup data belum berjalan optimal atau rutin.	4	3	43	12	4
2	Risiko Legal	Karena berkas rekam medis pasien tidak disimpan dengan sistem yang aman dan terstruktur, mungkin saja terjadi kehilangan atau kerusakan berkas rekam medis sehingga dapat menyebabkan	Sistem penyimpanan dan pengamanan berkas rekam medis belum optimal.	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		hambatan dalam pelayanan dan risiko tuntutan hukum.						
3	Risiko Operasional	Karena ketidaktepatan petugas dalam mengecek berkas rekam medis, mungkin saja terjadi kesalahan atau ketidaklengkapan data pasien sehingga dapat menyebabkan gangguan pelayanan maupun kesalahan administrasi.	Ketelitian petugas dalam verifikasi berkas belum optimal.	4	3	43	12	4

35. Kesekretariatan

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena surat masuk dan surat keluar tidak dikelola dan diarsipkan secara tertib, mungkin saja terjadi kehilangan dokumen penting sehingga dapat menyebabkan hambatan dalam pengambilan keputusan dan tata	Sistem pengarsipan dokumen kesekretariatan belum terstruktur dengan baik.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		kelola rumah sakit.						
2	Risiko Kebijakan	Karena regulasi dan kebijakan internal rumah sakit tidak didistribusikan atau disosialisasikan secara merata kepada seluruh unit, mungkin saja terjadi ketidakseragaman implementasi kebijakan sehingga dapat mengganggu tata kelola pelayanan dan kepatuhan standar.	Mekanisme distribusi dan sosialisasi kebijakan internal belum berjalan efektif.	3	3	33	9	6
3	Risiko Kepatuhan	Karena notulensi dan tindak lanjut hasil rapat pimpinan tidak terdokumentasi dengan baik serta pengumpulan dokumen meeting rumah sakit (umandok) tidak dilakukan pada hari yang sama setelah rapat selesai, mungkin saja keputusan penting tidak ditindaklanjuti tepat waktu sehingga	Tidak ada mekanisme monitoring tindak lanjut hasil rapat secara sistematis.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		dapat menghambat pelaksanaan program dan kebijakan rumah sakit.						

36. Gudang Umum

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena stok barang habis pakai tidak dimonitor secara rutin, mungkin saja terjadi kekosongan stok barang sehingga dapat menyebabkan terganggunya operasional pelayanan di seluruh unit rumah sakit.	Sistem monitoring dan pengadaan stok barang habis pakai belum optimal.	4	3	43	12	4
2	Risiko Operasional	Karena penyimpanan barang di gudang tidak sesuai standar (suhu, kelembapan, tata letak), mungkin saja terjadi kerusakan atau penurunan kualitas barang sehingga dapat menyebabkan kerugian dan terhambatnya	Kondisi penyimpanan dan SOP penataan gudang belum memenuhi standar.	3	3	33	9	6



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		pemenuhan kebutuhan unit.						
3	Risiko Fraud	Karena sistem pencatatan keluar masuk barang di gudang tidak tertib dan tidak diverifikasi secara berkala, mungkin saja terjadi kehilangan atau penyimpangan barang sehingga dapat merugikan rumah sakit secara finansial.	Pengawasan dan audit stok gudang belum dilakukan secara rutin dan konsisten.	4	2	42	8	7

37. Asuransi Center

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena sistem e-klaim mengalami gangguan atau tidak berfungsi, mungkin saja proses klaim kepada penjamin tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga terjadi keterlambatan arus kas yang berdampak pada stabilitas keuangan	Gangguan server e-klaim	5	3	53	15	3



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		rumah sakit.						
2	Risiko Operasional	Karena beban kerja yang tinggi dan tidak seimbang, mungkin saja petugas Asuransi Center mengalami kelelahan (fatigue) dan stres kerja, sehingga terjadi penurunan kinerja yang dapat memengaruhi ketepatan, kecepatan, dan kualitas proses pelayanan serta pengelolaan klaim.	Peningkatan volume klaim atau pasien tanpa penambahan SDM.	4	3	43	12	4
3	Risiko Operasional	Karena petugas terpapar layar komputer secara terus-menerus tanpa jeda yang cukup, mungkin saja mengalami kelelahan mata dan gangguan penglihatan, sehingga konsentrasi dan produktivitas kerja menurun serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.	Durasi penggunaan komputer yang terlalu lama tanpa istirahat.	4	2	42	8	7



38. MOD-MPP-PIPP

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena adanya keluarga pasien emosional dan miskomunikasi di unit PIPP, mungkin saja terjadi kekerasan verbal/fisik terhadap petugas, sehingga mengganggu keselamatan dan pelayanan.	Dikarenakan adanya keluarga pasien emosional & miskomunikasi	4	4	44	16	2
2	Risiko Klinis	Karena adanya ketidakpuasan dan miskomunikasi pelayanan di unit PIPP, mungkin saja terjadi pencemaran nama baik perusahaan, sehingga menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.	Dikarenakan Penanganan komplain yang lambat/tidak tuntas	4	4	44	16	2
3	Risiko Reputasi	Karena penanganan komplain yang lambat atau tidak tuntas, mungkin saja terjadi	Petugas PIPP 4 orang yang juga menangani sebagai MOD	2	2	22	4	9



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		viral negatif di media sosial, sehingga menurunkan kepercayaan pasien dan mencemarkan nama baik rumah sakit.	dan MPP ruangan, sehingga untuk MPP kurang maksimal					

39. Pendaftaran

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena terjadi gangguan internet/jaringan pada sistem rumah sakit, mungkin saja staf tidak dapat mengidentifikasi data-data pasien sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan maupun kesalahan identifikasi pasien.	Koneksi jaringan dan sistem informasi rumah sakit tidak stabil.	4	4	44	16	2
2	Risiko Operasional	Karena petugas kurang teliti pada saat akan mencetak surat penjaminan, mungkin saja SEP tidak tercetak sehingga dapat	Ketelitian petugas dalam proses pencetakan SEP belum optimal.	4	3	43	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		menyebabkan pelayanan tidak dapat diklaimkan.						
3	Risiko Klinis	Kurangnya data pada saat proses mendaftarkan, kemungkinan terjadinya rekam medis ganda sehingga ditakutkan terjadinya IKP	Kurangnya data pada saat proses mendaftarkan	3	4	34	12	4

40. Rehab Medis

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Operasional	Karena keterbatasan waktu pelayanan dan jumlah tenaga di unit rehabilitasi medis, mungkin terapi yang diberikan lebih dominan berupa terapi alat dan terapi latihan hanya diajarkan di awal, sehingga efektivitas rehabilitasi pasien dapat menurun dan hasil terapi menjadi kurang optimal.	Keterbatasan ruang dan fasilitas terapi latihan.	4	3	43	12	4
2	Risiko	Karena jumlah	Distribusi	3	4	34	12	4



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
	Operasional	fisioterapis tidak seimbang dengan beban pelayanan, mungkin saja waktu tunggu pasien menjadi lama sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan ketidakpuasan pasien.	jadwal dan rasio fisioterapis terhadap pasien belum optimal.					
3	Risiko Klinis	Karena peralatan rehabilitasi medis tidak dikalibrasi dan dipelihara secara berkala, mungkin saja terjadi kerusakan alat saat digunakan sehingga dapat menyebabkan cedera pada pasien dan terganggunya pelayanan rehabilitasi.	Jadwal pemeliharaan dan kalibrasi alat rehabilitasi belum dilaksanakan secara rutin.	3	3	33	9	6

41. Kasir

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
1	Risiko Fraud	Karena kasir berada di tempat terbuka dan	Area kasir berada di lokasi	3	2	32	6	8



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		petugas jaga malam bekerja sendiri, mungkin saja terjadi pencurian terhadap uang kas, sehingga menyebabkan kerugian keuangan bagi rumah sakit	terbuka sehingga mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.					
2	Risiko Operasional	Karena sistem informasi kasir/SIMRS mengalami gangguan atau down, mungkin saja proses pembayaran pasien menjadi terhambat sehingga dapat menyebabkan antrian panjang, keterlambatan pelayanan, dan ketidakpuasan pasien.	Ketergantungan pada sistem informasi tanpa prosedur manual cadangan yang memadai saat downtime.	2	3	23	6	8
3	Risiko Legal	Karena kesalahan penghitungan atau penagihan biaya layanan kepada pasien, mungkin saja terjadi sengketa pembayaran antara pasien dan rumah sakit sehingga dapat	Verifikasi rincian tagihan pasien sebelum pembayaran belum dilakukan secara optimal.	2	2	22	4	9



No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Concat (D&P)	Scoring	Ranking
		menimbulkan komplain, tuntutan hukum, dan penurunan kepercayaan masyarakat.						

A. MITIGASI RISIKO

1. Instalasi Kamar Operasi

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kegagalan dalam penentuan lokasi operasi akibat ketidakpatuhan surgical safety checklist dan komunikasi buruk	15	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Sosialisasi dan pengawasan kepatuhan surgical safety checklist - Briefing dan time out sebelum operasi - Audit kepatuhan checklist secara berkala - Peningkatan komunikasi efektif antar tim operasi	Kepatuhan penggunaan surgical safety checklist meningkat dan kesalahan lokasi operasi dapat dicegah	Diharapkan dalam waktu 6 bulan grading menurun menjadi kuning/hijau	IKO
2	Risiko infeksi luka operasi akibat ketidakpatuhan bundle	12	Reduksi kerugian (Mengurangi	- Monitoring kepatuhan bundle PPI	Kepatuhan bundle PPI meningkat dan angka infeksi luka	Diharapkan dalam waktu 6 bulan angka infeksi menurun dan	IKO



	pencegahan infeksi		Dampak)	- Pelatihan sterilisasi dan bundle infeksi - Audit kepatuhan hand hygiene dan sterilitas alat - Evaluasi rutin kejadian infeksi luka operasi	operasi menurun	grading hijau menjadi	
3	Risiko reaksi anestesi berat akibat ketidaktepatan pemberian anestesi	12	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Verifikasi identitas pasien dan alergi sebelum tindakan - Double check dosis dan jenis obat anestesi - Monitoring ketat selama tindakan anestesi - Pelatihan keselamatan pemberian anestesi	Ketepatan pemberian anestesi meningkat dan kejadian reaksi anestesi menurun	Diharapkan dalam waktu 6 bulan tidak terjadi insiden reaksi anestesi berat dan grading menjadi hijau	IKO

2. Unit IT

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko pelayanan terganggu akibat kegagalan sistem jaringan	16	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Monitoring jaringan dan server secara berkala - Maintenance sistem dan	Stabilitas jaringan meningkat dan gangguan pelayanan akibat sistem menurun	Diharapkan dalam waktu 6 bulan downtime sistem menurun dan grading menjadi kuning	IT



				- perangkat IT rutin - Penyediaan jaringan cadangan (<i>backup network</i>) - Pembuatan SOP penanganan gangguan sistem			
2	Risiko kehilangan data penting rumah sakit akibat tidak adanya backup data	16	Transfer / Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	- Penerapan backup data harian dan berkala - Penyimpanan backup di server/cloud cadangan - Monitoring keberhasilan backup data - Uji restore data secara rutin	Keamanan dan ketersediaan data rumah sakit meningkat	Diharapkan dalam waktu 6 bulan sistem backup berjalan optimal dan grading menjadi kuning	IT
3	Risiko kebocoran data pasien akibat perlindungan data elektronik tidak optimal	12	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Edukasi dan pelatihan cyber security bagi petugas - Penguatan password dan akses sistem - Pembatasan hak akses data pasien - Audit keamanan sistem informasi secara berkala	Kepatuhan keamanan data meningkat dan risiko kebocoran data menurun	Diharapkan dalam waktu 6 bulan tidak terjadi insiden kebocoran data dan grading menjadi hijau	IT



3. Instalasi Rawat Jalan

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko keterlambatan pelayanan akibat dokter datang tidak sesuai jadwal	15	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Monitoring ketepatan waktu dokter - Evaluasi jadwal pelayanan secara berkala - Koordinasi aktif antara dokter dan petugas pendaftaran - Penerapan SOP keterlambatan pelayanan	Waktu tunggu pasien menurun dan kepuasan pasien meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan keterlambatan pelayanan menurun dan komplain pasien berkurang	Instalasi Rawat Jalan
2	Risiko penularan infeksi airborne akibat ketidakpatuhan pasien TB menggunakan masker	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Edukasi penggunaan masker kepada pasien TB - Penyediaan masker di area pelayanan - Pengawasan kepatuhan penggunaan masker - Penerapan SOP pencegahan dan pengendalian infeksi	Kepatuhan penggunaan masker meningkat dan risiko transmisi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan pasien meningkat dan risiko infeksi airborne menurun	Instalasi Rawat Jalan



3	Risiko pelayanan terganggu akibat AC tidak berfungsi optimal	12	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Maintenance dan servicing AC secara rutin - Monitoring suhu ruangan berkala - Penyediaan AC cadangan atau kipas tambahan - Pembuatan jadwal pemeliharaan AC	Kenyamanan pasien dan petugas meningkat serta gangguan pelayanan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan keluhan terkait suhu ruangan menurun dan kualitas pelayanan meningkat	Instalasi Rawat Jalan
---	--	----	--	--	--	--	-----------------------

4. Driver

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kecelakaan operasional kendaraan rumah sakit akibat unsafe action dan unsafe condition	8	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Sosialisasi SOP keselamatan berkendara - Monitoring kepatuhan driver - Pemeriksaan kendaraan secara rutin - Pelatihan safety driving bagi driver	Kepatuhan driver meningkat dan risiko kecelakaan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan angka kecelakaan operasional menurun dan keselamatan transportasi meningkat	Driver
2	Risiko paparan penyakit akibat petugas tidak menggunakan APD saat penjemputan/pengantaran pasien	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Edukasi penggunaan APD kepada petugas - Penyediaan APD lengkap - Pengawasan kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan penyakit menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD meningkat dan kejadian paparan menurun	Driver



				- Monitoring penerapan PP			
3	Risiko keterlambatan transportasi pasien akibat jumlah permintaan operasional melebihi kapasitas driver	6	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Pengaturan jadwal operasional driver - Koordinasi antar unit ditingkatkan - Evaluasi kebutuhan SDM transportasi - Monitoring waktu pelayanan transportasi	Pelayanan transportasi pasien lebih optimal dan keterlambatan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu transportasi pasien menurun dan pelayanan lebih efektif	Driver

5. ATEM

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko paparan radiasi pada pasien akibat error alat CT Scan	12	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Monitoring dan pengecekan alat CT Scan secara rutin - Kalibrasi alat berkala - Penerapan SOP penggunaan alat - Pelatihan petugas radiologi	Keamanan penggunaan CT Scan meningkat dan risiko paparan radiasi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan error alat CT Scan menurun dan keselamatan pasien meningkat	ATEM
2	Risiko ketidaksesuaian pemberian cairan/obat akibat error pada Syringe Pump	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Maintenance Syringe Pump secara berkala - Kalibrasi alat rutin - Monitoring	Ketepatan pemberian cairan dan obat meningkat serta error alat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kejadian error Syringe Pump menurun dan keselamatan pasien	ATEM



				penggunaan alat oleh petugas - Penerapan SOP penggunaan alat		meningkat	
3	Risiko hasil monitoring ECG tidak akurat akibat gel elektroda mengering atau berkerak	6	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	- Pembersihan alat dan aksesoris ECG secara rutin - Penggantian elektroda secara berkala - Monitoring kualitas alat sebelum digunakan - Penerapan SOP pemeriksaan ECG	Keakuratan hasil ECG meningkat dan gangguan pembacaan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan hasil pembacaan ECG lebih akurat dan keluhan gangguan alat menurun	ATEM

6. IPSRS

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko pelayanan terganggu akibat kerusakan alat karena pemeliharaan dan pengecekan tidak optimal	20	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun dan menerapkan jadwal preventive maintenance - Melakukan uji fungsi alat secara berkala - Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP pemeliharaan	Kondisi alat lebih terjaga dan kejadian kerusakan alat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan pemeliharaan meningkat dan gangguan pelayanan akibat kerusakan alat menurun	IPSRS



				- Dokumentasi dan evaluasi hasil pemeliharaan alat			
2	Risiko kelelahan kerja petugas akibat overload pekerjaan	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Pengaturan beban kerja dan jadwal kerja petugas - Evaluasi kebutuhan SDM secara berkala - Penerapan waktu istirahat yang cukup - Monitoring kondisi kesehatan dan kelelahan petugas	Beban kerja lebih seimbang dan kelelahan petugas menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kejadian kelelahan kerja menurun dan produktivitas petugas meningkat	IPSRS
3	Risiko tersengat listrik saat pemeriksaan atau perbaikan alat akibat kebocoran arus listrik	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Pemeriksaan instalasi dan grounding listrik secara berkala - Penggunaan APD saat bekerja - Pengujian kebocoran arus pada alat kesehatan dan peralatan listrik - Pelatihan K3 kelistrikan bagi petugas	Keamanan kerja meningkat dan risiko kecelakaan listrik menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi insiden sengatan listrik dan kepatuhan K3 meningkat	IPSRS

7. Laundry

No	Risiko	Jumlah	Upaya Mitigasi	Residual	Pemilik
----	--------	--------	----------------	----------	---------



		skor risiko	Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	Risiko
1	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat proses dekontaminasi linen terkontaminasi yang tidak optimal	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan dan penggunaan APD lengkap saat dekontaminasi linen - Pelatihan penanganan linen terkontaminasi sesuai PPI - Supervisi kepatuhan penggunaan APD - Monitoring proses dekontaminasi secara berkala	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan infeksi menurun	Laundry
2	Risiko penularan infeksi akibat penanganan linen infeksius yang tidak sesuai prosedur	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan implementasi SOP penanganan linen infeksius - Pelatihan PPI bagi petugas laundry - Audit kepatuhan penanganan linen infeksius - Penyediaan sarana dan bahan dekontaminasi	Kepatuhan terhadap prosedur PPI meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak ditemukan ketidaksesuaian penanganan linen infeksius dan risiko transmisi infeksi menurun	Laundry



				yang memadai			
3	Risiko needle stick injury pada petugas akibat benda tajam tercampur dalam linen kotor	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Edukasi pemisahan benda tajam dan limbah medis kepada seluruh unit - Pemeriksaan linen sebelum proses pencucian - Penggunaan sarung tangan tahan tusuk sesuai kebutuhan - Monitoring dan pelaporan insiden benda tajam	Kejadian needle stick injury menurun dan keselamatan petugas meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi needle stick injury akibat linen kotor dan kepatuhan pemilahan limbah meningkat	Laundry

8. CSSD

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penularan infeksi pada petugas akibat paparan darah atau cairan tubuh saat proses dekontaminasi	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan dan penggunaan APD sesuai standar - Pelatihan PPI dan dekontaminasi alat kesehatan - Supervisi kepatuhan penggunaan	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan petugas menurun	CSSD



				APD - Monitoring kejadian paparan petugas			
2	Risiko infeksi pada petugas akibat paparan alat kotor atau terkontaminasi saat proses penerimaan alat	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penerapan SOP penerimaan alat kotor secara konsisten - Penggunaan APD lengkap saat penerimaan alat - Pelatihan penanganan alat terkontaminasi - Audit kepatuhan SOP secara berkala	Kepatuhan SOP meningkat dan risiko infeksi petugas menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kejadian infeksi akibat paparan alat kotor dan kepatuhan SOP meningkat	CSSD
3	Risiko infeksi nosokomial (HAIs) pada pasien akibat kontaminasi silang alat kesehatan	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Pemisahan area dan alur alat bersih serta alat kotor - Monitoring proses pembersihan dan sterilisasi alat - Validasi dan kontrol mutu proses sterilisasi - Audit kepatuhan SOP CSSD secara berkala	Kualitas sterilisasi alat meningkat dan risiko kontaminasi silang menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan proses sterilisasi mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian HAIs terkait alat kesehatan menurun	CSSD

9. Cleaning Service

No	Risiko	Jumlah skor	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik	Mitigasi risiko yang	Output	Target	



		risiko	Pengendalian risiko	dilakukan			
1	Risiko needle stick injury pada petugas cleaning service akibat jarum bekas tercampur dalam sampah atau linen medis	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi pembuangan benda tajam ke safety box sesuai SOP - Monitoring kepatuhan pemilahan limbah medis - Penggunaan APD yang sesuai saat pengangkutan sampah dan linen - Pelaporan dan investigasi setiap kejadian needle stick injury	Kejadian needle stick injury menurun dan keselamatan petugas meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi needle stick injury akibat kesalahan pembuangan benda tajam dan kepatuhan pemilahan limbah meningkat	Cleaning Service
2	Risiko penularan infeksi pada petugas cleaning service akibat paparan lingkungan atau permukaan terkontaminasi	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan dan penggunaan APD sesuai standar - Pelatihan PPI bagi petugas cleaning service - Pengawasan kepatuhan penggunaan APD - Monitoring kesehatan dan kejadian pajanan petugas	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian pajanan infeksi menurun	Cleaning Service



3	Risiko cedera akibat terpeleset pada lantai licin saat kegiatan pembersihan	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Pembersihan tumpahan cairan segera setelah ditemukan - Pemasangan rambu "Lantai Basah" saat proses pembersihan - Penggunaan alas kaki anti-slip bagi petugas - Monitoring kepatuhan prosedur keselamatan kerja	Kejadian terpeleset dan cedera kerja menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi insiden terpeleset akibat lantai licin dan kepatuhan K3 meningkat	Cleaning Service
---	---	---	--	---	--	--	------------------

10. Kamar Jenazah

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penularan penyakit infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak standar atau robek	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan ukuran yang tepat - Pemeriksaan kondisi APD sebelum digunakan - Pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak ditemukan penggunaan APD yang tidak layak dan kejadian paparan infeksi menurun	Kamar Jenazah



				kepatuhan penggunaan APD oleh petugas			
2	Risiko tertukarnya jenazah akibat kegagalan identifikasi	10	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Verifikasi identitas jenazah dengan metode dua identitas (double check) - Pemeriksaan gelang identitas sebelum serah terima - Penerapan SOP identifikasi dan penyerahan jenazah - Dokumentasi dan saksi saat proses serah terima jenazah	Akurasi identifikasi jenazah meningkat dan risiko tertukar menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kejadian tertukar jenazah dan kepatuhan verifikasi identitas mencapai $\geq 100\%$	Kamar Jenazah
3	Risiko kesalahan identifikasi dan keterlambatan pelayanan akibat ketidaklengkapan pencatatan data transit jenazah	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penerapan formulir transit jenazah yang terstandar - Monitoring kelengkapan dokumentasi transit jenazah - Peningkatan koordinasi antarunit terkait proses transit - Audit rekam data transit secara	Kelengkapan data transit meningkat dan kesalahan identifikasi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kelengkapan pencatatan transit mencapai $\geq 95\%$ dan komplain terkait proses transit menurun	Kamar Jenazah



				berkala			
--	--	--	--	---------	--	--	--

11. Keamanan

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko gangguan pengawasan keamanan akibat CCTV rusak atau tidak berfungsi optimal	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan preventive maintenance CCTV secara berkala - Monitoring fungsi CCTV harian dan pelaporan kerusakan secara cepat - Menyusun jadwal inspeksi dan penggantian perangkat yang rusak - Menyediakan CCTV cadangan pada area risiko tinggi	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tingkat fungsi CCTV mencapai $\geq 95\%$ dan tidak ada area kritis yang tidak terpantau	Keamanan
2	Risiko penularan penyakit infeksi pada petugas security saat membantu pemindahan pasien	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menetapkan batas kewenangan security dalam pemindahan pasien - Pelatihan PPI dan	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi paparan infeksi pada petugas security dan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$	Keamanan

				penggunaan APD bagi petugas security - Penyediaan APD sesuai kebutuhan di area pelayanan - Monitoring kepatuhan penggunaan APD saat kontak dengan pasien			
3	Risiko kekerasan verbal maupun fisik dari keluarga pasien terhadap petugas terkait kebijakan jam besuk	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi kebijakan jam besuk melalui media informasi yang jelas - Pelatihan komunikasi efektif dan manajemen konflik bagi petugas - Pendampingan security pada situasi berisiko tinggi - Penerapan SOP penanganan keluarga pasien yang agresif	Kejadian konflik dan kekerasan terhadap petugas menurun	Diharapkan dalam 6 bulan jumlah insiden kekerasan verbal/fisik menurun dan kepatuhan terhadap aturan jam besuk meningkat	Keamanan

12. Instalasi Rawat Inap 2A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	



			risiko				
1	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check untuk obat berisiko tinggi - Evaluasi dan pelaporan insiden medik secara berkala	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan insiden kesalahan obat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian medication error menurun	Instalasi Rawat Inap 2A
2	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD yang memadai sesuai standar - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD - Monitoring kepatuhan penggunaan APD oleh petugas - Audit PPI secara berkala	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan infeksi menurun	Instalasi Rawat Inap 2A
3	Risiko ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan pasien akibat gangguan SIMRS saat pengisian E-RM	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Koordinasi dengan tim IT untuk penanganan gangguan sistem secara cepat - Monitoring	Kelengkapan dokumentasi rekam medis meningkat dan gangguan pelayanan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kelengkapan pengisian E-RM mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian error SIMRS menurun	Instalasi Rawat Inap 2A



				performa SIMRS secara berkala - Penyediaan prosedur downtime SIMRS - Verifikasi dan kelengkapan data setelah sistem kembali normal			
--	--	--	--	--	--	--	--

13. Instalasi Rawat Inap 2C

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check untuk obat berisiko tinggi - Evaluasi dan pelaporan insiden medik secara berkala	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan insiden kesalahan obat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian medication error menurun	Instalasi Rawat Inap 2C
2	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD yang memadai sesuai standar - Edukasi dan pelatihan	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan	Instalasi Rawat Inap 2C



				penggunaan APD - Monitoring kepatuhan penggunaan APD oleh petugas - Audit PPI secara berkala		infeksi menurun	
3	Risiko penularan infeksi akibat pengunjung masuk tanpa izin dan tidak sesuai prosedur	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Pengawasan keluar masuk pengunjung secara ketat - Sosialisasi aturan kunjungan kepada keluarga pasien - Penerapan skrining dan pembatasan pengunjung sesuai kebijakan RS - Monitoring kepatuhan terhadap prosedur kunjungan	Kepatuhan pengunjung terhadap aturan kunjungan meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prosedur kunjungan mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian pelanggaran kunjungan menurun	Instalasi Rawat Inap 2C

14. Instalasi Rawat Inap 3A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko keselamatan insiden pasien akibat tidak	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip benar	Kepatuhan pemberian obat meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip benar	Instalasi Rawat Inap 3A



	diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat			- pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check untuk obat berisiko tinggi - Evaluasi dan pelaporan insiden medik secara berkala	insiden kesalahan obat menurun	mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian medication error menurun	
2	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD yang memadai sesuai standar - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD - Monitoring kepatuhan penggunaan APD oleh petugas - Audit PPI secara berkala	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan infeksi menurun	Instalasi Rawat Inap 3A
3	Risiko ketidaklengkapan dokumentasi pelayanan pasien akibat gangguan SIMRS saat pengisian E-RM	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Koordinasi dengan tim IT untuk penanganan gangguan sistem secara cepat - Monitoring performa SIMRS secara berkala - Penyediaan prosedur	Kelengkapan dokumentasi rekam medis meningkat dan gangguan pelayanan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kelengkapan pengisian E-RM mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian error SIMRS menurun	Instalasi Rawat Inap 3A



				downtime SIMRS - Verifikasi dan kelengkapan data setelah sistem kembali normal			
--	--	--	--	---	--	--	--

15. Instalasi Rawat Inap 3C

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penularan infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak lengkap saat kontak dengan pasien	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan unit - Edukasi serta pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan penggunaan APD secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian pajanan infeksi menurun	Instalasi Rawat Inap 3C
2	Risiko infeksi nosokomial akibat petugas tidak melakukan hand hygiene saat tindakan invasif	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen hand hygiene - Penyediaan fasilitas hand	Kepatuhan hand hygiene meningkat dan risiko infeksi nosokomial menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan hand hygiene mencapai $\geq 95\%$ dan angka infeksi nosokomial menurun	Instalasi Rawat Inap 3C



				hygiene yang memadai - Audit kepatuhan hand hygiene secara berkala - Pemberian umpan balik hasil audit kepada petugas			
3	Risiko pasien jatuh akibat handrail tempat tidur tidak terpasang	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Edukasi petugas mengenai pencegahan risiko jatuh - Penerapan checklist keselamatan pasien sebelum meninggalkan pasien - Supervisi pemasangan handrail setelah tindakan/perawatan - Monitoring dan evaluasi insiden pasien jatuh kembali normal	Kepatuhan pemasangan handrail meningkat dan kejadian pasien jatuh menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan pemasangan handrail mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi insiden pasien jatuh akibat handrail tidak terpasang	Instalasi Rawat Inap 3C

16. Instalasi Rawat Inap 4A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	



1	Risiko pasien mengalami nyeri, hematoma, atau komplain akibat penusukan vena lebih dari dua kali	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan asesmen kondisi vena sebelum tindakan - Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan pemasangan infus dan pengambilan darah - Menggunakan alat bantu vein finder bila tersedia - Melakukan eskalasi kepada petugas yang lebih kompeten apabila gagal dua kali penusukan	Keberhasilan penusukan vena pada percobaan pertama meningkat dan keluhan pasien menurun	Diharapkan dalam 6 bulan angka penusukan vena >2 kali menurun dan kepuasan pasien meningkat	Instalasi Rawat Inap 4A
2	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check pada obat high alert - Pelaporan dan	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan medication error menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan IKP terkait obat menurun	Instalasi Rawat Inap 4A



				evaluasi insiden keselamatan pasien secara berkala			
3	Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan penggunaan APD secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan cairan tubuh menurun	Instalasi Rawat Inap 4A

17. Instalasi Rawat Inap 5C

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penularan infeksi akibat penanganan pasien infeksius yang tidak sesuai prosedur	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan implementasi SOP PPI pada pasien infeksius - Penerapan isolasi sesuai jenis transmisi penyakit - Monitoring kepatuhan	Kepatuhan terhadap prosedur PPI meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan PPI mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian transmisi infeksi menurun	Instalasi Rawat Inap 5C



				petugas terhadap prosedur PPI - Audit dan evaluasi kejadian infeksi secara berkala			
2	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi penggunaan APD sesuai jenis risiko paparan - Supervisi dan audit kepatuhan penggunaan APD - Monitoring kejadian paparan petugas	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan infeksi menurun	Instalasi Rawat Inap 5C
3	Risiko peningkatan infeksi akibat ketidakpatuhan hand hygiene	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi 5 momen hand hygiene kepada seluruh petugas - Penyediaan fasilitas hand hygiene yang memadai di setiap area pelayanan - Audit kepatuhan hand hygiene secara berkala - Pemberian umpan balik dan	Kepatuhan hand hygiene meningkat dan angka infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan hand hygiene mencapai $\geq 95\%$ dan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan menurun	Instalasi Rawat Inap 5C



				tindak lanjut hasil audit			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

18. Instalasi Rawat Inap 6A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM secara berkala - Optimalisasi distribusi jadwal dan pembagian tugas - Penyesuaian penempatan staf sesuai beban kerja - Monitoring indikator beban kerja dan waktu tunggu pelayanan	Pelayanan lebih optimal dan beban kerja staf lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu pelayanan menurun dan keluhan terkait keterlambatan pelayanan berkurang	Instalasi Rawat Inap 6A
2	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check pada obat high	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan kejadian medication error menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan IKP terkait pemberian obat menurun	Instalasi Rawat Inap 6A



				alert - Evaluasi dan pelaporan insiden keselamatan pasien secara berkala			
3	Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan penggunaan APD secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan cairan tubuh menurun	Instalasi Rawat Inap 6A

19. Instalasi Rawat Inap 7A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM secara berkala - Optimalisasi distribusi jadwal dan pembagian tugas - Penyesuaian	Pelayanan lebih optimal dan beban kerja staf lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu pelayanan menurun dan keluhan terkait keterlambatan pelayanan berkurang	Instalasi Rawat Inap 7A



				penempatan staf sesuai beban kerja - Monitoring indikator beban kerja dan waktu tunggu pelayanan			
2	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check pada obat high alert - Evaluasi dan pelaporan insiden keselamatan pasien secara berkala	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan kejadian medication error menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan IKP terkait pemberian obat menurun	Instalasi Rawat Inap 7A
3	Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan cairan tubuh menurun	Instalasi Rawat Inap 7A



				secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit			
--	--	--	--	---	--	--	--

20. Instalasi Rawat Inap 8A

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM secara berkala - Optimalisasi distribusi jadwal dan pembagian tugas - Penyesuaian penempatan staf sesuai beban kerja - Monitoring indikator beban kerja dan waktu tunggu pelayanan	Pelayanan lebih optimal dan beban kerja staf lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu pelayanan menurun dan keluhan terkait keterlambatan pelayanan berkurang	Instalasi Rawat Inap 8A
2	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan prinsip 7 benar pemberian obat - Supervisi dan audit kepatuhan pemberian obat - Penerapan double check	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan kejadian medication error menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan IKP terkait pemberian obat menurun	Instalasi Rawat Inap 8A



				pada obat high alert - Evaluasi dan pelaporan insiden keselamatan pasien secara berkala			
3	Risiko paparan infeksi pada staf/perawat akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan penggunaan APD secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan cairan tubuh menurun	Instalasi Rawat Inap 8A

21. Instalasi Gawat Darurat

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kesalahan terapi atau tindakan akibat miskomunikasi antar tenaga kesehatan	20	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menerapkan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR - Melakukan read back dan repeat	Komunikasi antar tenaga kesehatan lebih efektif dan kejadian kesalahan terapi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan komunikasi SBAR mencapai $\geq 95\%$ dan insiden akibat miskomunikasi menurun	Instalasi Gawat Darurat



				back pada instruksi verbal/telepon - Meningkatkan koordinasi dan handover antar tenaga kesehatan - Audit kepatuhan komunikasi efektif secara berkala			
2	Risiko perburukan kondisi pasien akibat keterlambatan pemberian tindakan awal di IGD	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Optimalisasi pelaksanaan triase sesuai prioritas kegawatn - Monitoring response time tenaga kesehatan - Evaluasi kecukupan SDM pada jam sibuk - Simulasi dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan secara berkala	Waktu respons pelayanan IGD lebih cepat dan keselamatan pasien meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan response time IGD sesuai standar dan keterlambatan tindakan awal menurun	Instalasi Gawat Darurat
3	Risiko penularan infeksi pada petugas maupun pasien lain akibat penanganan pasien infeksius di IGD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penerapan kewaspadaan standar dan transmisi sesuai jenis penyakit - Penyediaan dan penggunaan APD	Kepatuhan PPI meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD dan prosedur PPI mencapai $\geq 95\%$ serta tidak terjadi transmisi infeksi terkait	Instalasi Gawat Darurat

				sesuai indikasi - Skrining dan pemisahan pasien infeksius sejak triase - Audit kepatuhan PPI dan penggunaan APD secara berkelanjutan hasil audit		pelayanan di IGD	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

22. Instalasi Care Unit

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terjadinya infeksi VAP akibat audit bundle pencegahan yang tidak dilakukan secara rutin	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan audit bundle VAP secara berkala - Monitoring kepatuhan pelaksanaan bundle VAP harian - Supervisi dan umpan balik hasil audit kepada petugas - Evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan	Kepatuhan pelaksanaan bundle VAP meningkat dan angka VAP menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan bundle VAP mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian VAP menurun	Instalasi Care Unit



2	Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kekurangan staf	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja - Optimalisasi jadwal dinas dan pembagian tugas petugas - Pengajuan penambahan SDM sesuai kebutuhan unit - Monitoring indikator mutu dan waktu respons pelayanan	Pelayanan pasien lebih optimal dan beban kerja petugas lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan keterlambatan pelayanan menurun dan capaian indikator mutu unit meningkat	Instalasi Care Unit
3	Risiko penularan infeksi akibat tindakan aerosol yang tidak dilakukan secara aman	10	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penerapan SOP tindakan aerosol sesuai standar PPI - Penggunaan APD sesuai indikasi (masker N95, face shield, dll.) - Pelaksanaan tindakan aerosol di area dengan ventilasi yang memadai - Audit kepatuhan petugas terhadap prosedur tindakan aerosol	Kepatuhan prosedur tindakan aerosol meningkat dan risiko penularan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prosedur tindakan aerosol mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi transmisi infeksi terkait tindakan aerosol	Instalasi Gawat Darurat



23. Instalasi Gizi

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kondisi pasien memburuk akibat pemberian diet yang tidak sesuai	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi jenis diet pasien sebelum distribusi makanan - Penerapan sistem double check antara ahli gizi dan petugas distribusi - Sosialisasi SOP pemberian diet kepada petugas terkait - Monitoring dan evaluasi kesesuaian diet pasien secara berkala	Ketepatan pemberian diet dan diet meningkat kesalahan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan verifikasi diet mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian kesalahan pemberian diet menurun	Instalasi Gizi
2	Risiko malnutrisi tidak teridentifikasi akibat skrining nutrisi yang tidak dilakukan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan skrining nutrisi pada seluruh pasien sesuai ketentuan - Monitoring kepatuhan pelaksanaan skrining nutrisi	Cakupan skrining nutrisi meningkat dan pasien berisiko malnutrisi teridentifikasi lebih awal	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan skrining nutrisi mencapai $\geq 95\%$ dan keterlambatan intervensi gizi menurun	Instalasi Gizi



				- Edukasi petugas mengenai pentingnya skrining nutrisi - Audit dan evaluasi hasil skrining secara berkala			
3	Risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian penyediaan diet pasien akibat kekurangan stok bahan makanan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Monitoring stok bahan makanan secara rutin - Menetapkan stok minimum (buffer stock) bahan makanan utama - Melakukan perencanaan kebutuhan bahan makanan berdasarkan jumlah pasien - Evaluasi dan koordinasi dengan bagian pengadaan secara berkala	Ketersediaan bahan makanan terjaga dan pelayanan gizi berjalan optimal	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kekosongan bahan makanan yang mengganggu pelayanan diet pasien	Instalasi Gizi

24. Radiologi

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kesalahan identifikasi pasien yang dapat menyebabkan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan identifikasi pasien	Kepatuhan identifikasi pasien meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan identifikasi pasien	Radiologi



	pemeriksaan atau tindakan radiologi tidak sesuai			menggunakan minimal dua identitas sebelum pemeriksaan - Penerapan double check antara data SIMRS, formulir permintaan, dan identitas pasien - Sosialisasi SOP identifikasi pasien kepada seluruh petugas radiologi - Audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala	kejadian salah identifikasi menurun	mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi insiden salah pasien	
2	Risiko terganggunya pelayanan radiologi akibat kekurangan staf	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja - Optimalisasi jadwal kerja dan pembagian tugas petugas - Pengajuan penambahan SDM sesuai kebutuhan unit - Monitoring waktu tunggu dan capaian pelayanan	Pelayanan radiologi lebih optimal dan beban kerja petugas lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu pemeriksaan menurun dan capaian pelayanan meningkat	Radiologi



				radiologi			
3	Risiko keterlambatan pemeriksaan pasien akibat gangguan atau kerusakan alat CT Scan	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan preventive maintenance dan kalibrasi alat secara berkala - Pemeriksaan fungsi alat sebelum operasional harian - Koordinasi cepat dengan teknisi/vendor saat terjadi gangguan - Menyusun prosedur contingency plan apabila alat tidak dapat digunakan	Keandalan alat CT Scan meningkat dan gangguan pelayanan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan downtime alat CT Scan menurun dan pelayanan radiologi berjalan sesuai standar	Radiologi

25. Laboratorium

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kesalahan hasil pemeriksaan dan diagnosis akibat identifikasi pasien atau spesimen yang tidak tepat	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan identifikasi pasien dan spesimen menggunakan minimal dua identitas	Kepatuhan identifikasi pasien dan spesimen meningkat serta kesalahan pemeriksaan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan identifikasi mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi insiden salah spesimen	Laboratorium



				- Penerapan double check sebelum pemeriksaan dan pelabelan spesimen - Sosialisasi dan pelatihan SOP identifikasi pasien dan spesimen - Audit kepatuhan identifikasi secara berkala			
2	Risiko keterlambatan pelayanan dan human error akibat kekurangan SDM laboratorium	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja laboratorium - Optimalisasi jadwal kerja dan pembagian tugas petugas - Pengajuan penambahan SDM sesuai kebutuhan unit - Monitoring waktu tunggu hasil pemeriksaan dan beban kerja petugas	Pelayanan laboratorium lebih optimal dan beban kerja petugas lebih seimbang	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu hasil pemeriksaan menurun dan kejadian human error berkurang	Laboratorium
3	Risiko needle stick injury pada petugas laboratorium akibat	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan pelatihan keselamatan	Kepatuhan prosedur keselamatan kerja meningkat dan	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi needle stick injury dan	Laboratorium



	penanganan jarum atau benda tajam yang tidak aman			kerja serta penanganan benda tajam - Penyediaan safety box di area kerja yang mudah dijangkau - Monitoring kepatuhan pembuangan benda tajam sesuai SOP - Pelaporan dan investigasi setiap kejadian needle stick injury	kejadian needle stick injury menurun	kepatuhan pembuangan benda tajam mencapai $\geq 95\%$	
--	---	--	--	---	--------------------------------------	---	--

26. Komite K3RS

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya pelayanan akibat kerusakan alat dan kegagalan uji fungsi	20	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun dan melaksanakan jadwal preventive maintenance secara rutin - Melakukan uji fungsi alat secara berkala dan terdokumentasi - Monitoring kepatuhan pelaksanaan pemeliharaan	Keandalan alat meningkat dan gangguan pelayanan akibat kerusakan alat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan preventive maintenance mencapai $\geq 95\%$ dan downtime alat menurun	K3RS



				alat - Evaluasi dan tindak lanjut segera terhadap alat yang mengalami gangguan			
2	Risiko kelelahan kerja dan penurunan kesehatan staf akibat overload pekerjaan	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Evaluasi beban kerja dan kebutuhan SDM secara berkala - Optimalisasi pembagian tugas dan jadwal kerja petugas - Pengaturan waktu istirahat yang memadai - Monitoring kesehatan dan tingkat kelelahan petugas	Beban kerja lebih seimbang dan kondisi kesehatan staf lebih terjaga	Diharapkan dalam 6 bulan keluhan kelelahan kerja menurun dan produktivitas staf meningkat	K3RS
3	Risiko korsleting atau sengatan listrik akibat kabel listrik terbuka	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Inspeksi rutin kondisi instalasi listrik dan sarana pendukung - Perbaikan atau pengamanan segera terhadap kabel yang rusak atau terbuka - Pemasangan pelindung dan penandaan area berisiko	Kondisi instalasi listrik lebih aman dan risiko kecelakaan listrik menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak ditemukan kabel terbuka yang tidak tertangani dan tidak terjadi insiden sengatan listrik maupun korsleting	K3RS



				- Sosialisasi K3 kelistrikan kepada petugas			
--	--	--	--	---	--	--	--

27. Tim PKRS

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kesalahan penyampaian informasi medis saat pergantian shift akibat ketidakpatuhan terhadap SPO Komunikasi Efektif	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan refreshment SPO Komunikasi Efektif (SBAR) - Monitoring dan audit pelaksanaan handover antar petugas - Penerapan read back dan konfirmasi ulang informasi penting - Evaluasi kepatuhan petugas terhadap SPO komunikasi	Komunikasi antar petugas lebih efektif dan kesalahan informasi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan komunikasi efektif mencapai $\geq 95\%$ dan komplain akibat miskomunikasi menurun	PKRS
2	Risiko ketidakpatuhan pasien terhadap instruksi medis akibat kendala bahasa dan penggunaan istilah medis	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami pasien - Memanfaatkan media edukasi	Pemahaman pasien terhadap instruksi medis meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan tingkat pemahaman pasien terhadap edukasi mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian ketidakpatuhan	PKRS



				- visual atau leaflet - Melakukan metode teach back untuk memastikan pemahaman pasien - Melibatkan keluarga sebagai pendamping edukasi bila diperlukan		menurun	
3	Risiko edukasi kesehatan tidak tersampaikan secara optimal akibat informasi dan media edukasi yang tidak diperbarui	2	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan review dan pembaruan media edukasi secara berkala - Menyesuaikan materi edukasi dengan regulasi dan kondisi lapangan terbaru - Menyusun daftar media edukasi yang terstandar - Monitoring efektivitas penyampaian edukasi kepada pasien dan keluarga	Materi edukasi lebih aktual dan mudah dipahami	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh media edukasi telah diperbarui sesuai regulasi terbaru dan tingkat kepuasan edukasi meningkat	PKRS

28. Komite PPI

No	Risiko	Jumlah skor	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik	Mitigasi risiko yang	Output	Target	



		risiko	Pengendalian risiko	dilakukan			
1	Risiko terjadinya Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs) akibat penerapan PPI yang belum optimal	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Monitoring implementasi bundle pencegahan HAIs (SSI, CAUTI, VAP, CLABSI/PLABSI) secara berkala - Audit kepatuhan pelaksanaan bundle di seluruh unit pelayanan - Pemberian umpan balik dan tindak lanjut hasil audit - Edukasi dan pelatihan PPI kepada petugas secara rutin	Kepatuhan pelaksanaan bundle HAIs meningkat dan angka HAIs menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan bundle HAIs mencapai $\geq 95\%$ dan angka HAIs menurun sesuai target rumah sakit	PPI
2	Risiko penyebaran mikroorganisme akibat ketidakpatuhan hand hygiene 5 momen	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan audit hand hygiene secara rutin - Penyediaan sarana hand hygiene yang memadai di seluruh area pelayanan - Sosialisasi dan refreshment 5 momen hand	Kepatuhan hand hygiene meningkat dan risiko infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan hand hygiene mencapai $\geq 85-95\%$ sesuai target rumah sakit dan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan menurun	PPI

				hygiene - Pemberian umpan balik hasil audit kepada unit terkait bila diperlukan			
3	Risiko paparan dan penularan infeksi akibat penggunaan APD yang tidak adekuat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan jenis risiko paparan - Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD sesuai indikasi - Monitoring ketersediaan APD di setiap unit pelayanan	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan infeksi pada petugas maupun pasien menurun	PPI

29. SDM

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko ketidakstabilan tenaga kerja akibat tingginya turnover staf yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan analisis kebutuhan SDM berbasis beban kerja secara berkala - Meningkatkan program retensi	Stabilitas SDM meningkat dan pelayanan lebih optimal	Diharapkan dalam 6 bulan angka turnover menurun dan kepuasan pasien meningkat	SDM



				dan kepuasan karyawan - Melaksanakan orientasi dan pendampingan bagi staf baru - Monitoring angka turnover dan evaluasi penyebabnya secara rutin			
2	Risiko tenaga kesehatan berpraktik dengan SIP yang tidak berlaku sehingga menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan regulasi	8	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Membuat sistem monitoring masa berlaku SIP, STR, dan kredensial tenaga kesehatan - Pemberian notifikasi sebelum masa berlaku izin berakhir - Monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen perizinan secara berkala - Koordinasi aktif dengan tenaga kesehatan terkait perpanjangan izin praktik	Kepatuhan pengelolaan SIP dan kredensial meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh tenaga kesehatan memiliki SIP aktif dan valid (100%)	SDM
3	Risiko sengketa hubungan kerja akibat pengelolaan kontrak dan dokumen kepegawaian	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menata dan mendigitalisasi arsip dokumen kepegawaian	Dokumen kepegawaian lebih tertib dan mudah ditelusuri	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh dokumen kepegawaian	SDM



	yang tidak tertib			secara sistematis - Melakukan audit kelengkapan dokumen kepegawaian secara berkala - Menyusun SOP pengelolaan kontrak dan dokumen SDM - Monitoring masa berlaku kontrak kerja dan dokumen pendukung unit pelayanan		terdokumentasi lengkap dan tidak terjadi sengketa akibat kelengkapan dokumen	
--	-------------------	--	--	---	--	--	--

30. Humas & Marketing

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penurunan citra rumah sakit akibat penyebaran informasi negatif atau keluhan pasien di media digital	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan monitoring media sosial dan platform digital secara rutin - Menyusun strategi manajemen isu dan krisis komunikasi - Menindaklanjuti keluhan pasien secara cepat dan	Citra rumah sakit terjaga dan isu negatif dapat ditangani lebih cepat	Diharapkan dalam 6 bulan waktu respons terhadap isu digital meningkat dan jumlah keluhan yang viral menurun	Humas & Marketing



				- profesional - Meningkatkan publikasi informasi positif dan edukatif tentang rumah sakit			
2	Risiko menurunnya kepercayaan masyarakat akibat komentar, review, atau pemberitaan negatif yang viral	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun SOP penanganan keluhan dan isu publik - Membentuk tim respons cepat untuk pengelolaan media digital - Melakukan klarifikasi dan komunikasi publik secara tepat waktu - Monitoring kepuasan pasien dan tren opini masyarakat	Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan tingkat kepuasan pasien meningkat dan jumlah isu negatif yang tidak tertangani menurun	Humas & Marketing
3	Risiko miskomunikasi kepada masyarakat dan stakeholder akibat penyampaian informasi digital yang tidak terkontrol	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun standar komunikasi dan publikasi media digital - Melakukan verifikasi dan persetujuan informasi sebelum	Informasi yang disampaikan lebih akurat, konsisten, dan terpercaya	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kesalahan informasi publik dan seluruh publikasi mengikuti standar komunikasi rumah sakit	Humas & Marketing



				dipublikasikan - Menunjuk juru bicara atau admin resmi rumah sakit - Melakukan evaluasi berkala terhadap konten dan media komunikasi			
--	--	--	--	--	--	--	--

31. Farmasi

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kesalahan pelayanan dan pemberian obat akibat kelelahan petugas farmasi yang bekerja lebih dari 8 jam	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menata ulang jadwal kerja dan sistem shift sesuai beban kerja - Memastikan waktu istirahat petugas terpenuhi sesuai ketentuan - Melakukan evaluasi kebutuhan SDM farmasi secara berkala - Monitoring kejadian medication error yang berkaitan dengan	Beban kerja petugas lebih seimbang dan risiko kesalahan pelayanan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan jadwal kerja sesuai ketentuan meningkat dan kejadian kesalahan akibat kelelahan menurun	Farmasi



				kelelahan kerja			
2	Risiko kesalahan penginputan e-resep yang dapat menyebabkan cedera atau membahayakan pasien	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi dan validasi e-resep sebelum dispensing obat - Menerapkan double check pada resep berisiko tinggi (high alert) - Meningkatkan ketelitian petugas melalui edukasi dan supervisi berkala - Monitoring dan evaluasi kejadian kesalahan input resep	Akurasi input e-resep meningkat dan kesalahan penginputan menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kejadian kesalahan input e-resep menurun dan kepatuhan verifikasi resep mencapai $\geq 95\%$	Farmasi
3	Risiko kesalahan penyiapan obat LASA yang dapat menyebabkan salah obat atau salah pasien	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menerapkan double check secara konsisten pada obat LASA - Memberikan penandaan khusus (label/stiker) pada obat LASA - Menata penyimpanan obat LASA secara terpisah sesuai standar	Kepatuhan pengelolaan obat LASA meningkat dan kejadian salah obat menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan double check obat LASA mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi insiden salah obat akibat LASA	Farmasi



				- Melakukan audit kepatuhan penyediaan dan dispensing obat LASA			
--	--	--	--	---	--	--	--

32. Maternitas

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko insiden keselamatan pasien akibat tidak diterapkannya prinsip 7 benar pemberian obat	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Sosialisasi dan refreshment prinsip 7 benar pemberian obat - Audit kepatuhan pemberian obat secara berkala - Penerapan double check pada obat high alert - Evaluasi dan pelaporan IKP secara rutin	Kepatuhan pemberian obat meningkat dan medication error menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan prinsip 7 benar mencapai $\geq 95\%$ dan IKP terkait pemberian obat menurun	Maternitas
2	Risiko paparan infeksi pada petugas akibat ketidakpatuhan penggunaan APD	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Penyediaan APD sesuai standar dan kebutuhan pelayanan - Edukasi dan pelatihan penggunaan APD yang benar - Monitoring kepatuhan	Kepatuhan penggunaan APD meningkat dan risiko paparan infeksi menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan penggunaan APD mencapai $\geq 95\%$ dan kejadian paparan cairan tubuh menurun	Maternitas



				penggunaan APD secara berkala - Audit PPI dan tindak lanjut hasil audit input resep			
3	Risiko terganggunya pelayanan pasien akibat kondisi AC bocor di ruang maternitas	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan perbaikan AC yang bocor segera setelah ditemukan kerusakan - Menyusun dan melaksanakan jadwal preventive maintenance AC secara berkala - Melakukan inspeksi rutin kondisi sarana dan prasarana ruangan - Melaporkan dan menindaklanjuti kerusakan melalui sistem pelaporan sarana	Kondisi ruangan lebih nyaman dan pelayanan pasien tidak terganggu	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terdapat AC bocor yang mengganggu pelayanan dan seluruh AC berfungsi dengan baik	Maternitas

33. Neonatologi

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya pelayanan pasien neonatus akibat	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan preventive maintenance	Keandalan fasilitas dan alat medis meningkat serta	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi gangguan pelayanan	Neonatologi



	kegagalan fasilitas dan infrastruktur (inkubator, listrik, gas medis)			fasilitas dan alat medis secara berkala - Melakukan pengecekan harian fungsi inkubator, listrik cadangan, dan gas medis - Menyusun dan mensosialisasikan prosedur penanganan kegagalan fasilitas (contingency plan) - Koordinasi rutin dengan IPSRS dan elektromedis terkait kondisi sarana	gangguan pelayanan menurun	akibat kegagalan fasilitas kritis dan kepatuhan pemeliharaan mencapai $\geq 95\%$	
2	Risiko cedera jaringan, nekrosis, atau deformitas hidung akibat pemasangan nasal CPAP yang tidak optimal	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan monitoring posisi dan tekanan nasal CPAP secara berkala - Melaksanakan asesmen kondisi kulit dan jaringan sekitar hidung setiap shift - Edukasi petugas mengenai teknik pemasangan	Kejadian cedera akibat penggunaan CPAP menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi nekrosis atau cedera jaringan akibat pemasangan CPAP dan kepatuhan SOP mencapai $\geq 95\%$	Neonatalogi



				CPAP yang benar - Supervisi dan audit kepatuhan terhadap SOP penggunaan CPAP			
3	Risiko tertukarnya identitas bayi yang dapat menyebabkan kesalahan pemberian advis maupun pelayanan	8	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menerapkan identifikasi bayi menggunakan gelang identitas sesuai standar - Melakukan verifikasi identitas bayi dengan dua identitas sebelum tindakan atau pemberian advis - Menerapkan double check oleh petugas saat serah terima pasien - Audit kepatuhan identifikasi pasien bayi secara berkala	Kepatuhan identifikasi bayi meningkat dan kejadian identitas dicegah	Diharapkan dalam 6 bulan kepatuhan identifikasi bayi mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi insiden tertukarnya identitas bayi	Neonatalogi

34. Rekam Medis

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kehilangan data rekam medis akibat tidak tersedianya backup data	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melaksanakan backup data rekam medis	Keamanan dan ketersediaan data rekam medis terjaga	Diharapkan dalam 6 bulan pelaksanaan backup data	Rekam Medis



	yang memadai			secara rutin dan terjadwal - Menyimpan backup pada media dan lokasi yang berbeda (offsite/cloud) - Melakukan uji pemulihan (restore test) secara berkala - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan backup data		mencapai 100% sesuai jadwal dan tidak terjadi kehilangan data rekam medis	
2	Risiko kehilangan atau kerusakan berkas rekam medis yang dapat menyebabkan hambatan pelayanan dan tuntutan hukum	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan Menata sistem penyimpanan berkas rekam medis sesuai standar - Membatasi akses berkas hanya kepada petugas yang berwenang - Melakukan monitoring peminjaman dan pengembalian berkas - Menyediakan sarana penyimpanan yang aman dari kerusakan fisik,	Keamanan dan ketertelusuran berkas rekam medis meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kehilangan berkas rekam medis dan seluruh berkas tersimpan sesuai sistem yang berlaku	Rekam Medis



				kebakaran, dan kelembaban			
3	Risiko kesalahan atau ketidaklengkapan data pasien akibat ketidaktelitian petugas dalam verifikasi berkas rekam medis	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi kelengkapan berkas menggunakan checklist standar - Meningkatkan ketelitian petugas melalui sosialisasi dan supervisi berkala - Melaksanakan audit kelengkapan rekam medis secara rutin - Memberikan umpan balik atas temuan ketidaklengkapan dokumen	Kelengkapan dan akurasi data rekam medis meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan kelengkapan rekam medis mencapai $\geq 95\%$ dan kesalahan administrasi akibat data tidak lengkap menurun	Rekam Medis

35. Kesekretariatan

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kehilangan dokumen penting akibat pengelolaan dan pengarsipan surat masuk maupun surat keluar yang tidak tertib	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan surat masuk dan surat keluar	Pengelolaan surat lebih tertib dan dokumen mudah ditelusuri	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh surat masuk dan keluar terdokumentasi 100% serta tidak terjadi kehilangan dokumen	Kesekretariatan



				- Melakukan pengarsipan dokumen secara sistematis baik fisik maupun digital - Membuat register dan tracking surat secara berkala - Melakukan audit arsip dan kelengkapan dokumen secara rutin		penting	
2	Risiko ketidakseragaman implementasi kebijakan akibat distribusi dan sosialisasi regulasi yang tidak merata	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menetapkan mekanisme distribusi kebijakan ke seluruh unit secara terstruktur - Melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi terbaru secara berkala - Mendokumentasikan bukti sosialisasi dan daftar hadir peserta - Monitoring pemahaman dan implementasi kebijakan di unit	Kebijakan dan regulasi dipahami serta diterapkan secara seragam	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh kebijakan baru tersosialisasi ke 100% unit terkait dan tingkat kepatuhan meningkat	Kesekretariatan



				kejadian kelembaban			
3	Risiko keterlambatan tindak lanjut keputusan rapat akibat dokumentasi dan monitoring hasil rapat yang tidak optimal	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun notulen rapat dan umandok pada hari yang sama setelah rapat selesai - Membuat daftar tindak lanjut (action plan) beserta penanggung jawab dan target waktu - Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rapat secara berkala - Menyimpan dokumen rapat dalam sistem arsip yang mudah diakses	Tindak lanjut hasil rapat lebih terpantau dan tepat waktu	Diharapkan dalam 6 bulan 100% notulen dan umandok terdokumentasi tepat waktu serta tindak lanjut rapat terlaksana sesuai target	Kesekretariatan

36. Gudang Umum

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko terganggunya operasional pelayanan akibat kekosongan stok barang habis pakai	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan monitoring stok barang secara rutin dan berkala	Ketersediaan barang habis pakai terjaga dan pelayanan tidak terganggu	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi stock out pada barang habis pakai kritis dan	Gudang Umum



				- Menetapkan stok minimum (minimum stock level) dan reorder point - Mengoptimalkan perencanaan pengadaan berdasarkan pemakaian barang - Melakukan koordinasi rutin dengan unit pengguna terkait kebutuhan barang		tingkat ketersediaan stok mencapai $\geq 95\%$	
2	Risiko kerusakan atau penurunan kualitas barang akibat penyimpanan gudang yang tidak sesuai standar	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menata gudang sesuai standar suhu, kelembapan, dan tata letak penyimpanan - Melakukan monitoring suhu dan kelembapan gudang secara berkala - Menerapkan sistem FEFO/FIFO sesuai jenis barang - Melaksanakan inspeksi dan audit	Kualitas barang tetap terjaga dan kerusakan barang menurun	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh area penyimpanan memenuhi standar dan jumlah barang rusak menurun	Gudang Umum



				kondisi penyimpanan secara rutin			
3	Risiko kehilangan atau penyimpangan barang yang menyebabkan kerugian finansial rumah sakit	8	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menerapkan pencatatan keluar masuk barang secara real time dan terdokumentasi - Melakukan stock opname secara berkala - Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi stok fisik dengan sistem pencatatan - Melakukan audit internal gudang secara rutin	Pengelolaan stok lebih akurat dan risiko kehilangan barang menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kesesuaian stok fisik dengan data sistem mencapai $\geq 95\%$ dan tidak terjadi kehilangan barang yang signifikan	Gudang Umum

37. Asuransi Center

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko keterlambatan proses klaim akibat gangguan sistem e-klaim yang berdampak pada arus kas rumah sakit	15	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan monitoring server dan aplikasi e-klaim secara berkala - Berkoordinasi dengan tim IT dan vendor untuk	Proses klaim lebih lancar dan keterlambatan pengajuan klaim berkurang	Diharapkan dalam 6 bulan downtime sistem e-klaim menurun dan ketepatan waktu pengajuan klaim mencapai $\geq 95\%$	Asuransi Center



				- percepatan penanganan gangguan - Menyusun prosedur kerja manual sementara saat sistem mengalami downtime - Melakukan backup data klaim secara rutin			
2	Risiko penurunan kinerja petugas akibat kelelahan dan stres kerja karena beban kerja yang tinggi	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan evaluasi beban kerja dan kebutuhan SDM secara berkala - Optimalisasi pembagian tugas dan jadwal kerja petugas - Pengaturan waktu istirahat yang cukup selama jam kerja - Monitoring produktivitas dan kesehatan kerja petugas secara rutin	Beban kerja lebih seimbang dan produktivitas petugas meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan keluhan kelelahan kerja menurun dan ketepatan proses klaim meningkat	Asuransi Center
3	Risiko kelelahan mata dan penurunan konsentrasi akibat paparan layar komputer	8	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menerapkan aturan istirahat mata (20-20-20) secara berkala	Keluhan kelelahan mata berkurang dan ketelitian kerja meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan keluhan gangguan mata menurun dan	Asuransi Center



	secara terus-menerus			- Mengatur ergonomi posisi kerja dan pencahayaan ruangan - Menggunakan fitur filter cahaya biru pada monitor - Melakukan edukasi kesehatan kerja dan pemeriksaan kesehatan berkala		kesalahan input data berkurang	
--	----------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--

38. MOD-MPP-PIPP

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko kekerasan verbal atau fisik terhadap petugas akibat keluarga pasien yang emosional dan miskomunikasi di unit PIPP	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dan manajemen konflik petugas PIPP - Menyusun SOP penanganan keluarga pasien yang agresif atau emosional - Melibatkan petugas keamanan pada	Kejadian konflik dan kekerasan terhadap petugas menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kekerasan fisik terhadap petugas dan jumlah komplain terkait miskomunikasi menurun	MOD-MPP-PIPP



				situasi berisiko tinggi - Melakukan edukasi dan pemberian informasi yang jelas kepada pasien dan keluarga			
2	Risiko pencemaran nama baik rumah sakit akibat ketidakpuasan dan miskomunikasi pelayanan	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian komplain pasien - Melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut komplain secara berkala - Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait untuk penyelesaian masalah pasien - Memberikan pelatihan komunikasi pelayanan prima kepada petugas	Komplain terselesaikan lebih cepat dan kepuasan pasien meningkat	Diharapkan dalam 6 bulan $\geq 90\%$ komplain terselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan rumah sakit	MOD-MPP-PIPP
3	Risiko viral negatif di media sosial yang dapat menurunkan kepercayaan pasien dan mencemarkan nama	4	Kurangi kerugian (Mengurangi dampak)	- Menyusun mekanisme respons cepat terhadap keluhan yang berpotensi	Isu negatif dapat ditangani lebih cepat dan reputasi rumah sakit tetap terjaga	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh keluhan yang berpotensi viral ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam	MOD-MPP-PIPP



	baik rumah sakit			- viral - Monitoring media sosial dan kanal pengaduan secara rutin - Optimalisasi fungsi petugas PIPP, MOD, dan MPP melalui pengaturan tugas yang lebih efektif - Melakukan klarifikasi dan komunikasi publik yang tepat terhadap isu yang berkembang		dan tidak terjadi peningkatan keluhan publik di media sosial	
--	------------------	--	--	--	--	--	--

39. Pendaftaran

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko keterlambatan pelayanan dan kesalahan identifikasi pasien akibat gangguan internet/jaringan pada sistem rumah sakit	16	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan monitoring jaringan dan sistem informasi secara berkala - Menyediakan jalur internet cadangan (backup internet) - Menyusun prosedur downtime SIMRS	Ketersediaan sistem informasi meningkat dan gangguan pelayanan berkurang	Diharapkan dalam 6 bulan downtime jaringan menurun dan pelayanan tetap berjalan sesuai standar saat terjadi gangguan sistem	Pendaftar an



				untuk pelayanan saat sistem terganggu - Koordinasi cepat dengan tim IT saat terjadi gangguan jaringan			
2	Risiko klaim pelayanan tidak dapat diproses akibat SEP tidak tercetak	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi SEP sebelum pasien menyelesaikan proses pendaftaran - Menerapkan checklist pencetakan dan validasi SEP - Meningkatkan ketelitian petugas melalui sosialisasi dan supervisi berkala - Monitoring dan evaluasi kejadian SEP tidak tercetak	Kepatuhan pencetakan SEP meningkat dan klaim pelayanan lebih terjamin	Diharapkan dalam 6 bulan kejadian SEP tidak tercetak menurun hingga 0% dan seluruh pelayanan BPJS memiliki SEP yang valid	Pendaftar an
3	Risiko terjadinya rekam medis ganda akibat ketidaklengkapan data saat proses pendaftaran yang dapat menyebabkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum registrasi - Melakukan	Keakuratan data pasien meningkat dan kejadian rekam medis ganda menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kejadian rekam medis ganda menurun dan kepatuhan identifikasi pasien mencapai $\geq 95\%$	Pendaftar an



				pencarian data pasien secara menyeluruh pada SIMRS sebelum membuat nomor rekam medis baru - Meningkatkan kompetensi petugas pendaftaran terkait identifikasi pasien - Melakukan audit dan merging data rekam medis ganda secara berkala			
--	--	--	--	---	--	--	--

40. Rehab Medis

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko penurunan efektivitas rehabilitasi akibat keterbatasan waktu pelayanan, ruang, dan fasilitas terapi latihan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Mengoptimalkan penggunaan ruang dan fasilitas terapi latihan yang tersedia - Menyusun jadwal terapi yang lebih efektif sesuai kebutuhan pasien	Efektivitas terapi rehabilitasi meningkat dan hasil terapi lebih optimal	Diharapkan dalam 6 bulan kepuasan pasien dan capaian target terapi meningkat sesuai indikator unit	Rehab Medis



				- Menambah media edukasi dan panduan latihan mandiri bagi pasien - Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil terapi pasien			
2	Risiko keterlambatan pelayanan akibat jumlah fisioterapis yang tidak seimbang dengan beban pelayanan	12	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja - Mengoptimalkan distribusi jadwal pelayanan fisioterapis - Mengatur sistem appointment dan prioritas pasien sesuai kondisi klinis - Mengusulkan penambahan SDM bila diperlukan	Waktu tunggu pasien berkurang dan pelayanan lebih optimal	Diharapkan dalam 6 bulan waktu tunggu pelayanan sesuai standar rumah sakit dan tingkat kepuasan pasien meningkat	Rehab Medis
3	Risiko cedera pasien dan gangguan pelayanan akibat peralatan rehabilitasi yang tidak dikalibrasi atau dipelihara secara berkala	9	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Menyusun dan melaksanakan jadwal kalibrasi alat sesuai ketentuan - Melakukan preventive maintenance dan	Alat rehabilitasi berfungsi dengan baik dan aman digunakan	Diharapkan dalam 6 bulan 100% alat yang wajib kalibrasi telah dikalibrasi tepat waktu dan tidak terjadi insiden akibat kerusakan alat	Rehab Medis



				inspeksi rutin peralatan rehabilitasi - Mendokumentasi kan hasil pemeliharaan dan kalibrasi alat - Melaporkan serta menindaklanjuti segera apabila ditemukan kerusakan alat			
--	--	--	--	--	--	--	--

41. Kasir

No	Risiko	Jumlah skor risiko	Upaya Mitigasi		Residual		Pemilik Risiko
			Teknik Pengendalian risiko	Mitigasi risiko yang dilakukan	Output	Target	
1	Risiko pencurian uang kas akibat area kasir yang terbuka dan petugas jaga malam bekerja sendiri	6	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Memasang CCTV yang mengarah ke area kasir dan memastikan berfungsi optimal - Membatasi akses ke area kasir hanya untuk petugas yang berwenang - Melakukan penyetoran kas secara berkala sehingga tidak menumpuk di loket - Meningkatkan pengawasan security pada jam malam	Keamanan area kasir meningkat dan risiko pencurian menurun	Diharapkan dalam 6 bulan tidak terjadi kehilangan uang kas dan seluruh transaksi tercatat dengan baik	Kasir



2	Risiko keterlambatan pelayanan akibat gangguan sistem informasi kasir/SIMRS	6	Kurangi kerugian (Mengurangi dampak)	- Menyusun dan mensosialisasikan prosedur pelayanan manual saat downtime sistem - Berkoordinasi dengan tim IT untuk percepatan penanganan gangguan - Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala - Menyediakan formulir cadangan untuk proses pembayaran manual	Pelayanan tetap berjalan saat terjadi gangguan sistem	Diharapkan dalam 6 bulan seluruh petugas memahami prosedur downtime dan waktu gangguan sistem dapat diminimalkan	Kasir
3	Risiko sengketa pembayaran akibat kesalahan penghitungan atau penagihan biaya layanan pasien	4	Cegah kerugian (Mengurangi probabilitas)	- Melakukan verifikasi rincian tagihan sebelum pembayaran dilakukan - Menerapkan double check pada transaksi dengan nilai besar atau kompleks - Memberikan pelatihan kepada petugas terkait ketelitian penginputan tagihan - Melakukan audit transaksi dan evaluasi komplain	Akurasi tagihan meningkat dan komplain pembayaran menurun	Diharapkan dalam 6 bulan kesalahan tagihan menurun hingga 0% dan tidak terjadi sengketa pembayaran yang signifikan	Kasir



				secara berkala			
--	--	--	--	----------------	--	--	--

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Malang, 31 Desember 2025
Ketua Komite PMKP

dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp. M